AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 02 · IF · ATLAS

## ATLAS DE IMÁGENES EUNACOM ·

# ENFERMEDADES INFECCIOSAS

**Lo que tienes que ver en cada foto, y qué hacer después**

| 64 | 21 | 5 |
|---|---|---|
| IMÁGENES COMENTADAS CON MARCADORES | TEMAS, EN EL ORDEN DEL TOMO | PARES «PARECIDAS PERO DISTINTAS» |

Módulo 1 · Medicina Interna · complemento visual del Tomo 02

# Índice por tema

**Cómo usarlo.** Mira primero la foto y busca tú los hallazgos; después compara con los marcadores numerados y con «Qué tienes que ver». Cierra con la conducta y la pregunta real del pie. Al final, pruébate sin respuestas en la Autoevaluación.

Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento. «Tomo p.» = página del Tomo 02 donde se trata esa imagen o su tema.


**Parecidas pero distintas** 37

**Índice por tipo de imagen** 42

**Soluciones de la autoevaluación** 49

**Signos con nombre propio** 40

**Autoevaluación** 43

## 01 Urgencias Críticas, Sepsis e Infecciones del SNC

### 1.2 Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

01 Rigidez de nuca 4
02 Signo de Kernig 4
03 Púrpura meningocócica 5
04 Gram del LCR 5

### 1.3 Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral

05 Encefalitis herpética en RM 6
06 Abscesos cerebrales en anillo 6

### 1.4 Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig

07 Gangrena de Fournier 7
08 Fascitis necrotizante tras el desbridamiento 7
09 Angina de Ludwig 8

## 02 Salud Pública, Profilaxis Post-Exposición e IAAS

### 2.2 Rabia y Tétanos

10 Tétanos: risa sardónica y trismus 8
11 Tétanos: opistótonos 9

### 2.4 Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera

12 Cólera: heces en agua de arroz 9
13 Botulismo del lactante 10

## 03 Infecciones Crónicas, Retrovirales y Granulomatosas

### 3.2 Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

14 Neumonía por Pneumocystis jirovecii 10
15 Sarcoma de Kaposi 11
16 Toxoplasmosis cerebral 11

### 3.3 Tuberculosis

17 Tuberculosis miliar 12
18 Pleuritis tuberculosa: derrame unilateral 12
19 Escrófula (adenitis tuberculosa) 13
20 Baciloscopía: tinción de Ziehl-Neelsen 13

### 3.4 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I

21 Chancro sifilítico 14
22 Sífilis secundaria palmar 14
23 Condilomas planos 15
24 Dientes de Hutchinson 15

### 3.5 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II

25 Uretritis gonocócica 16
26 Herpes genital 16

## 04 Zoonosis, Medicina Tropical y Vectores

### 4.1 Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH)

27 Hantavirus: edema intersticial inicial 17
28 Hantavirus: edema pulmonar extenso 17

### 4.2 Enfermedad de Chagas

29 Vinchuca (Triatoma infestans) 18
30 Signo de Romaña 18
31 Cardiopatía chagásica: BCRD + HBAI 19

### 4.3 Enfermedades Transmitidas por Mosquitos

32 Exantema del dengue 20
33 Malaria: trofozoítos en anillo 20
34 Gametocitos en banana (P. falciparum) 21

### 4.4 Zoonosis Chilenas Endémicas

35 Quiste hidatídico hepático: vesículas hijas 21
36 Quiste hidatídico: signo del camalote 22
37 Quiste hidatídico pulmonar 22

# Índice por tema · continuación


### 4.5 Bacteriosis Zoonóticas

38 Leptospirosis: sufusión conjuntival ..... 23
39 Fiebre tifoidea: roséola tífica ..... 23

### 4.6 Ántrax (Carbunco Cutáneo y Respiratorio)

40 Carbunco cutáneo (pústula maligna) ..... 24
41 Carbunco inhalatorio: mediastino ensanchado ..... 24
42 Loxoscelismo cutáneo ..... 25
43 Ectima gangrenoso (Pseudomonas) ..... 25

## 05 Infecciones Comunitarias, Exantemas y Huésped Inmunocomprometido

### 5.1 Infecciones de Piel Comunitarias

44 Erisipela ..... 26
45 Celulitis ..... 26
46 Foliculitis ..... 27
47 Ántrax estafilocócico ..... 27

### 5.2 Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH

48 Linfocitos atípicos (de Downey) ..... 28
49 Amigdalitis del síndrome mononucleósico ..... 28
50 Faringoamigdalitis estreptocócica ..... 29
51 CMV congénito: calcificaciones periventriculares ..... 29

### 5.3 Exantemas Febriles de la Infancia

52 Manchas de Koplik ..... 30
53 Exantema del sarampión ..... 30
54 Exantema de la rubéola ..... 31
55 Kawasaki: labios fisurados y lengua en frambuesa ..... 31
56 Kawasaki: conjuntivitis bulbar sin pus ..... 32
57 Kawasaki: edema de manos ..... 32
58 Púrpura de Schönlein-Henoch ..... 33

### 5.4 Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster

59 Varicela: polimorfismo regional ..... 33
60 Varicela: cielo estrellado en la espalda ..... 34
61 Neumonitis varicelosa ..... 34

### 5.5 Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco

62 Aspergilosis invasora: signo del halo ..... 35
63 Mucormicosis rinocerebral ..... 35

### 5.6 Virus Respiratorios

64 MIS-C: compromiso digestivo ..... 36

## 01 TEMA 1.2 · MENINGITIS AGUDA BACTERIANA Y VIRAL

FOTO CLÍNICA

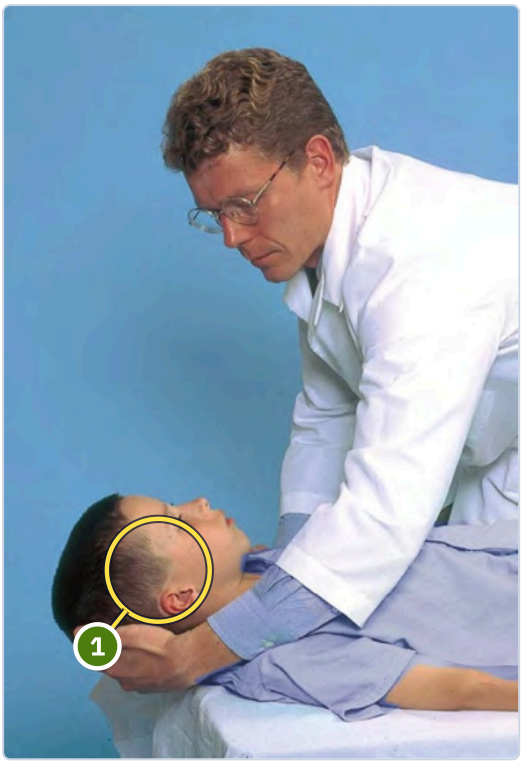



Imagen: Bates 12.ª ed., Fig. 18-72

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Resistencia al flectar el cuello: estira meninges inflamadas

**DIAGNÓSTICO**

### Rigidez de nuca

*Tríada meníngea: fiebre + rigidez de nuca + alteración mental.*

**CONDUCTA INICIAL**

Hemocultivos, dexametasona y ceftriaxona EV sin demora; PL salvo banderas rojas (TAC previo).

| | | |
|---|---|---|
| 1.04.2.006 | Meningitis aguda | Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 2.01.2.015 | Meningitis bacteriana | Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo |

**SE CONFUNDE CON…**

Meningismo de otras causas (HSA): sin fiebre previa, inicio en trueno.

**PREGUNTA REAL** **Julio 2017 · P81** «Un paciente de 65 años, consulta por fiebre y cefalea de 3 días de evolución, a lo que luego se agrega desorientación. Al examen físico se…» → **Ceftriaxona endovenosa**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 10** Tema 1.2

**Clase 1.2** en video

## 02 TEMA 1.2 · MENINGITIS AGUDA BACTERIANA Y VIRAL

FOTO CLÍNICA

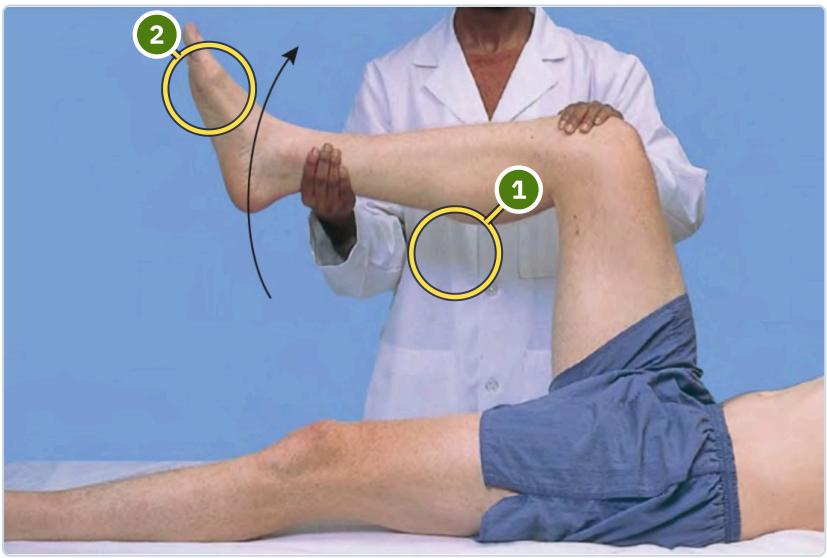



Imagen: Bates 12.ª ed., Fig. 17-62

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Cadera flectada a 90°
2. Extensión de la rodilla dolorosa

**DIAGNÓSTICO**

### Signo de Kernig

*Con la cadera flectada, extender la rodilla duele y ofrece resistencia.*

**CONDUCTA INICIAL**

Signos meníngeos positivos + fiebre: tratar como meningitis bacteriana y estudiar el LCR.

| | | |
|---|---|---|
| 1.04.2.006 | Meningitis aguda | Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Lasègue (ciática): dolor radicular, sin fiebre ni rigidez de nuca.

**PREGUNTA REAL** **Julio 2013 · P37** «Mujer de 23 años, con cuadro de 24 horas de evolución de compromiso del estado general, fiebre y soñolencia progresiva. Al examen físico destaca…» → **Meningitis meningococica**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 10** Tema 1.2

**Clase 1.2** en video

## 03 TEMA 1.2 · MENINGITIS AGUDA BACTERIANA Y VIRAL

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual CTO Infecciosas 14.ª ed., p. 38

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Púrpura extensa que no blanquea
2. Lesiones equimóticas confluentes

**DIAGNÓSTICO**

### Púrpura meningocócica

*Petequias que en horas pasan a equimosis y púrpura fulminante que no blanquea.*

**CONDUCTA INICIAL**

Ceftriaxona EV inmediata (antes de cualquier examen), soporte del shock y quimioprofilaxis a los contactos.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.01.2.016 | Meningococcemia | Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar |
| 1.04.2.006 | Meningitis aguda | Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Púrpura de Schönlein-Henoch: palpable, en extensores, sin shock.

PREGUNTA REAL

**Julio 2015 · P130** «Una paciente de 25 años presenta un cuadro de cefalea holocránea y fiebre alta. Al examen físico presenta rigidez de nuca y signo de Brudzinsky,...» → **Neisseria meningitidis**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 10** Tema 1.2

**Clase 1.2** en video

## 04 TEMA 1.2 · MENINGITIS AGUDA BACTERIANA Y VIRAL

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

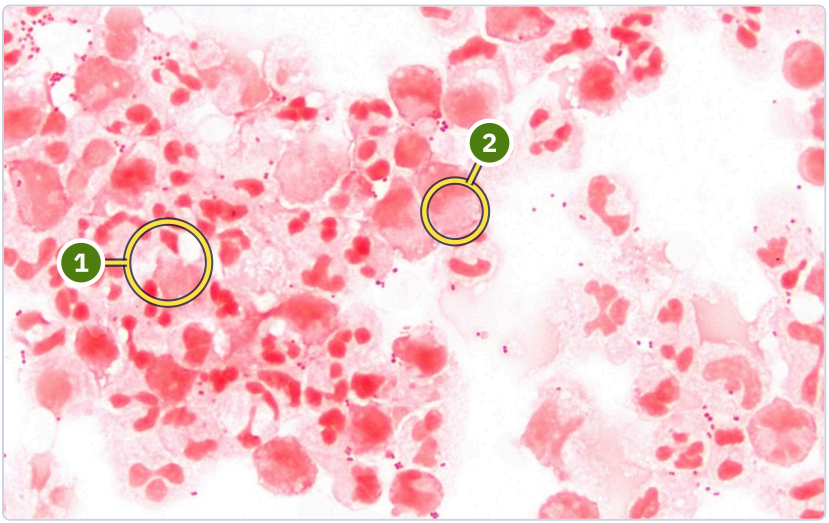



Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Neutrófilos
2. Diplococos entre las células

**DIAGNÓSTICO**

### Gram del LCR

*El Gram directo orienta en minutos: neutrófilos y cocos entre ellos.*

**CONDUCTA INICIAL**

Diplococos grampositivos lanceolados = neumococo; gramnegativos = meningococo. Se siembra en agar sangre y chocolate.

| | | |
|---|---|---|
| 1.04.4.006 | Estudio citoquímico de LCR | examen/procedimiento |
| 1.04.5.003 | Sembrar muestras para cultivo | examen/procedimiento |

**SE CONFUNDE CON…**

LCR viral: predominio linfocítico y glucosa normal.

PREGUNTA REAL

**Julio 2015 · P130** «Una paciente de 25 años presenta un cuadro de cefalea holocránea y fiebre alta. Al examen físico presenta rigidez de nuca y signo de Brudzinsky,...» → **Neisseria meningitidis**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 10** Tema 1.2

**Clase 1.2** en video

## 05 TEMA 1.3 · ENCEFALITIS AGUDA POR VHS Y ABSCESO CEREBRAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

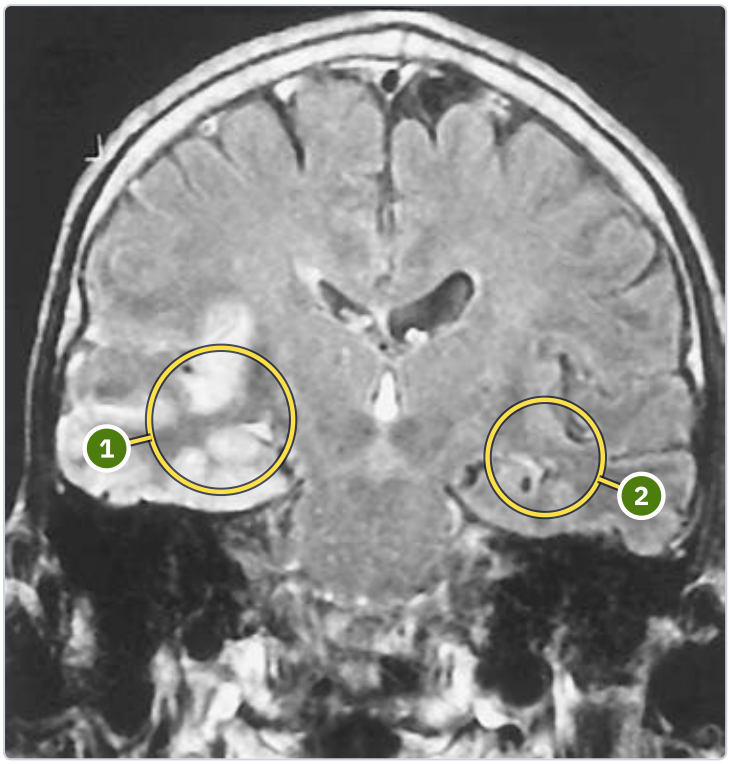



Imagen: Harrison 21.ª ed., p. 1137

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Lóbulo temporal hiperintenso
2. Asimetría: el otro lado menos tomado

**DIAGNÓSTICO**

### Encefalitis herpética en RM

*Hiperintensidad en T2/FLAIR temporal asimétrica y en la ínsula.*

**CONDUCTA INICIAL**

Aciclovir 10 mg/kg c/8 h EV de inmediato, sin esperar la PCR del LCR; 14-21 días.

`1.04.2.002` Encefalitis aguda — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

`1.10.2.014` Síndrome encefalítico (Herpes Simplex) — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

**SE CONFUNDE CON…**

Meningitis: sin alteración de funciones superiores ni lesión parenquimatosa.

PREGUNTA REAL — **Diciembre 2024 · P42** «Paciente con cefalea importante que convulsiona y tiene compromiso de conciencia? (soporoso?), con LCR MN y GR:» → **Encefalitis por VHS**

TOMO INFECTOLOGÍA p. 14 Tema 1.3

**Clase 1.3** en video

## 06 TEMA 1.3 · ENCEFALITIS AGUDA POR VHS Y ABSCESO CEREBRAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

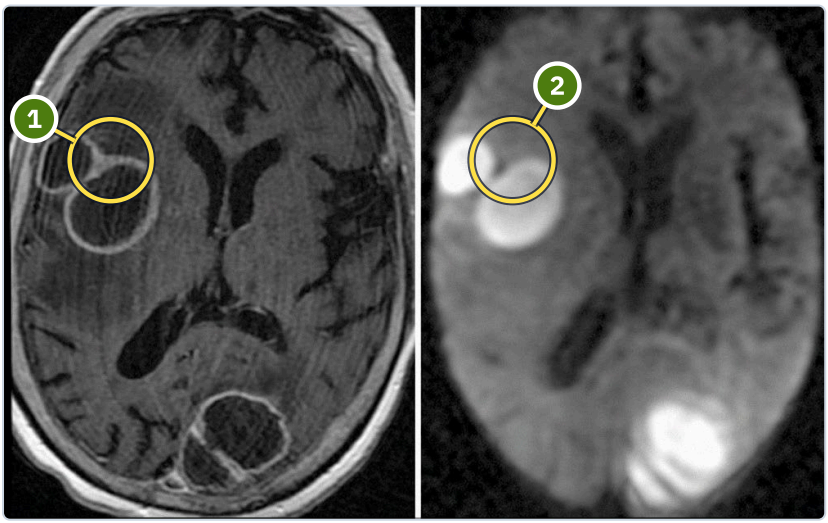



Imagen: Manual AMIR Infecciosas, p. 42

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Realce fino en anillo
2. Restricción a la difusión del contenido

**DIAGNÓSTICO**

### Abscesos cerebrales en anillo

*Lesiones con realce periférico en anillo y edema vasogénico alrededor.*

**CONDUCTA INICIAL**

Origen ótico o sinusal: ceftriaxona + metronidazol; drenaje según tamaño.

`1.04.2.001` Absceso cerebral — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Toxoplasmosis en VIH y tumores necróticos: también realzan en anillo.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA p. 14 Tema 1.3

**Clase 1.3** en video

## 07 TEMA 1.4 · INFECCIONES INVASIVAS DE PARTES BLANDAS Y ANGINA DE LUDWIG

FOTO CLÍNICA




Imagen: Atlas EUNACOM 2026

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Piel violácea y necrótica en el periné

**DIAGNÓSTICO**

### Gangrena de Fournier

*Fascitis necrotizante del periné y los genitales: piel violácea con necrosis.*

**CONDUCTA INICIAL**

Urgencia quirúrgica igual que cualquier fascitis: desbridamiento y antibióticos de amplio espectro.

| | | |
|---|---|---|
| 1.04.2.005 | Infección invasiva de partes blandas: celulitis, fasceitis, miositis necrotizantes o septicémicas | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 6.01.2.005 | Fasceitis necrotizante | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Celulitis escrotal o absceso: sin necrosis ni toxicidad.

PREGUNTA REAL — **Diciembre 2019 · P135** «Un paciente de 48 años, diabético mal controlado, presenta una lesión en el muslo derecho, desde hace 5 días, que ha crecido y se ha asociado a…» → **Fasceítis necrotizante**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 17** Tema 1.4

**Clase 1.4** en video

## 08 TEMA 1.4 · INFECCIONES INVASIVAS DE PARTES BLANDAS Y ANGINA DE LUDWIG

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual CTO Infecciosas 14.ª ed., p. 84

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Desbridamiento amplio del tejido necrótico

**DIAGNÓSTICO**

### Fascitis necrotizante tras el desbridamiento

*Dolor desproporcionado, flictenas, crepitación y anestesia: el tratamiento es el pabellón.*

**CONDUCTA INICIAL**

Exploración quirúrgica urgente + meropenem, vancomicina y clindamicina; no esperar TAC.

| | | |
|---|---|---|
| 1.04.2.005 | Infección invasiva de partes blandas: celulitis, fasceitis, miositis necrotizantes o septicémicas | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 6.01.2.005 | Fasceitis necrotizante | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Celulitis: dolor acorde al aspecto y sin signos duros de necrosis.

PREGUNTA REAL — **Agosto 2021 · P172** «Un paciente de 53 años, diabético mal controlado, presenta una lesión en la pierna derecha, desde hace 2 días, que se ha extendido hasta alcanzar…» → **Fasceítis necrotizante**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 17** Tema 1.4

**Clase 1.4** en video

## 09 TEMA 1.4 · INFECCIONES INVASIVAS DE PARTES BLANDAS Y ANGINA DE LUDWIG

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual AMIR Otorrinolaringología, p. 55

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Aumento de volumen bajo la mandíbula

**DIAGNÓSTICO**

### Angina de Ludwig

*Celulitis bilateral submandibular y sublingual de origen dental.*

**CONDUCTA INICIAL**

Prioridad número 1: asegurar la vía aérea; luego antibiótico EV y drenaje.

1.04.2.004 **Flegmón submaxilar, submandibular y del piso de la boca**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Adenitis cervical: unilateral, sin piso de boca elevado.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 17** Tema 1.4

Clase 1.4 en video

## 10 TEMA 2.2 · RABIA Y TÉTANOS

FOTO CLÍNICA

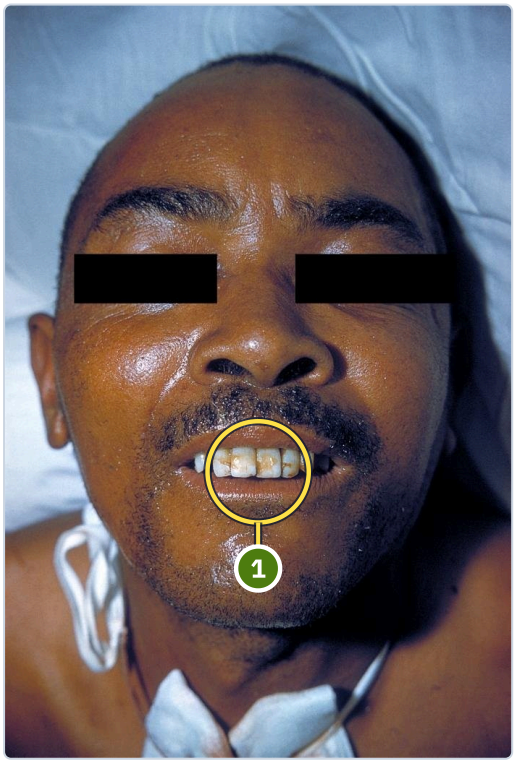



Imagen: CDC PHIL 2857, dominio público

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Mueca fija de la boca

**DIAGNÓSTICO**

### Tétanos: risa sardónica y trismus

*Espasmo del masetero y de la musculatura facial: mueca fija.*

**CONDUCTA INICIAL**

UCI en box oscuro, metronidazol, inmunoglobulina antitetánica 3.000-6.000 UI, sedación y relajantes.

1.04.2.009 **Tétanos**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Distonía aguda por fármacos: responde a biperideno.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 28** Tema 2.2

Clase 2.2 en video

## 11 TEMA 2.2 · RABIA Y TÉTANOS

FOTO CLÍNICA

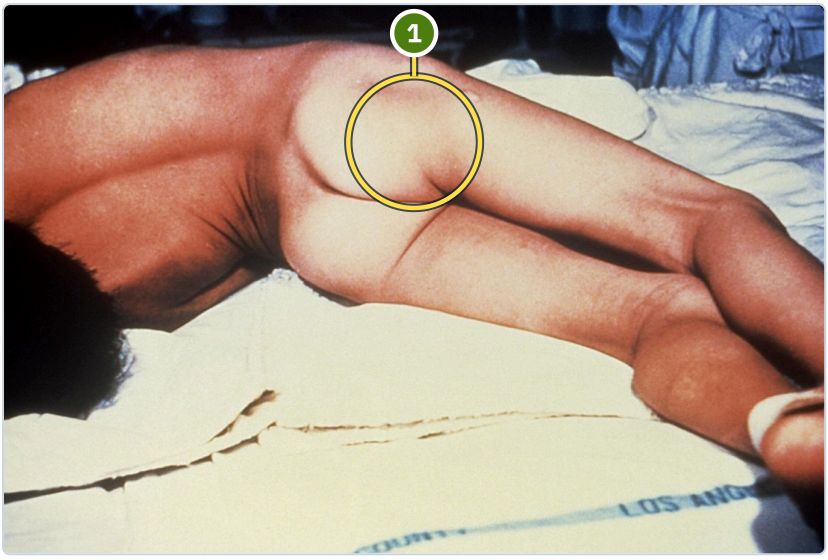



Imagen: CDC PHIL (Commons "PHIL tetanus"), dominio público

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Arco rígido de la espalda

**DIAGNÓSTICO**

### Tétanos: opistótonos

*Arco dorsal rígido por contracción de los músculos extensores.*

**CONDUCTA INICIAL**

Profilaxis: toxoide si > 10 años (limpia) o > 5 años (sucia); IGH-T si herida sucia con esquema < 3 dosis.

1.04.2.009 **Tétanos**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.04.3.008 **Profilaxis de tétanos**
examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

Convulsión tónica: con compromiso de conciencia.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 28** Tema 2.2

Clase 2.2 en video

## 12 TEMA 2.4 · INTOXICACIÓN ALIMENTARIA, BOTULISMO Y CÓLERA

FOTO CLÍNICA

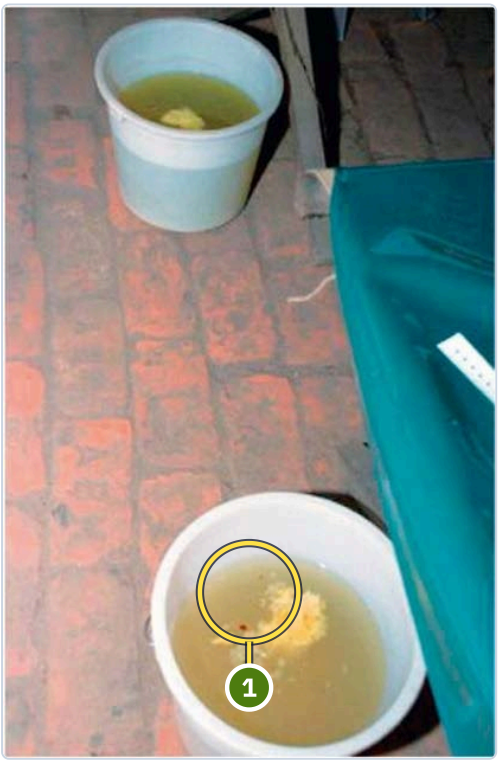



Imagen: Atlas EUNACOM 2026

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Heces líquidas con grumos blancos

**DIAGNÓSTICO**

### Cólera: heces en agua de arroz

*Diarrea acuosa masiva, blanquecina, sin sangre ni olor fétido.*

**CONDUCTA INICIAL**

Rehidratación agresiva + doxiciclina en dosis única; notificación.

1.04.1.007 **Cólera**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Diarrea disentérica: con sangre, fiebre y pujo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 33** Tema 2.4

Clase 2.4 en video

## 13 TEMA 2.4 · INTOXICACIÓN ALIMENTARIA, BOTULISMO Y CÓLERA

FOTO CLÍNICA

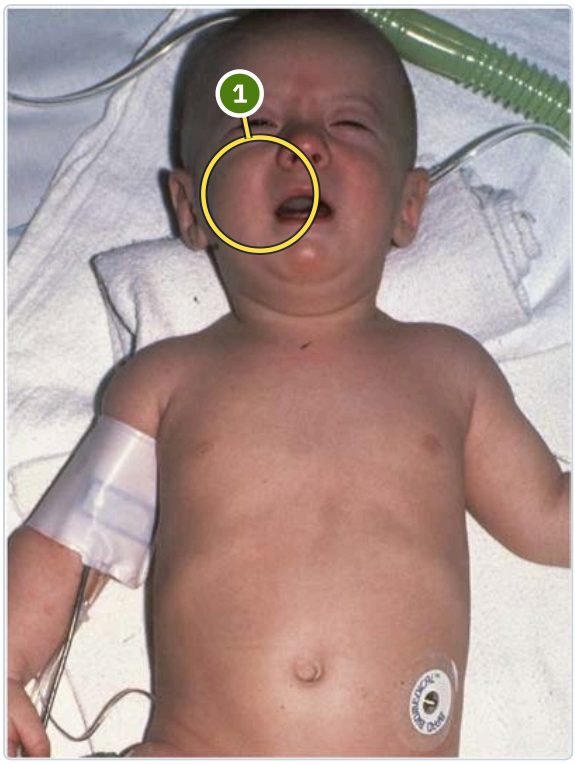



Imagen: Atlas EUNACOM 2026

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Cara inexpresiva, hipotonía

**DIAGNÓSTICO**

### Botulismo del lactante

*Hipotonía y cara poco expresiva en un lactante.*

**CONDUCTA INICIAL**

Evitar miel bajo el año de vida; soporte en UCI y antitoxina.

1.04.1.026 **Toxicoinfección alimentaria**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Sepsis o síndrome de Guillain-Barré: parálisis ascendente.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 33** Tema 2.4

Clase 2.4 en video

## 14 TEMA 3.2 · INFECCIONES OPORTUNISTAS MAYORES EN VIH/SIDA

IMAGEN RADIOLÓGICA

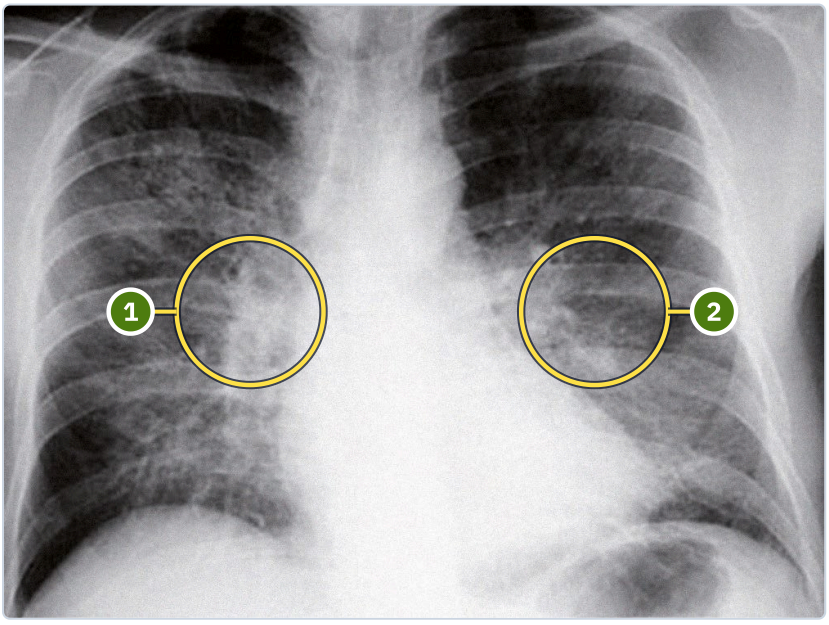



Imagen: Manual AMIR Infecciosas, p. 152

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Infiltrado intersticial bilateral
2. Simétrico, no un lóbulo condensado

**DIAGNÓSTICO**

### Neumonía por Pneumocystis jirovecii

*Infiltrado intersticial bilateral, perihiliar y difuso en un VIH con CD4 bajo.*

**CONDUCTA INICIAL**

Cotrimoxazol en dosis altas 21 días; corticoides si $PaO_2$ < 70 mmHg.

1.05.1.029 **Neumonías en inmunosuprimidos**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.04.1.014 **Infección por virus de inmunodeficiencia humana (SIDA)**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Neumonía neumocócica: condensación lobar.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2019 · P38** «Un paciente de 34 años, consulta por cuadro de 5 semanas de tos irritativa y expectoración que ha ido empeorando, agregándose disnea de medianos…» → **Neumonía por Pneumocystis jiroveci**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 43** Tema 3.2

Clase 3.2 en video

## 15 TEMA 3.2 · INFECCIONES OPORTUNISTAS MAYORES EN VIH/SIDA

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual AMIR Infecciosas, p. 157

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Placas violáceas en la pierna

**DIAGNÓSTICO**

### Sarcoma de Kaposi

*Placas eritemato-violáceas infiltradas en la piel: pista de VIH avanzado.*

**CONDUCTA INICIAL**

Estudiar VIH e iniciar TARV.

1.04.1.014 Infección por virus de inmunodeficiencia humana (SIDA)

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Púrpura y hematomas: no infiltrados.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA p. 43 Tema 3.2

Clase 3.2 en video

## 16 TEMA 3.2 · INFECCIONES OPORTUNISTAS MAYORES EN VIH/SIDA

IMAGEN RADIOLÓGICA

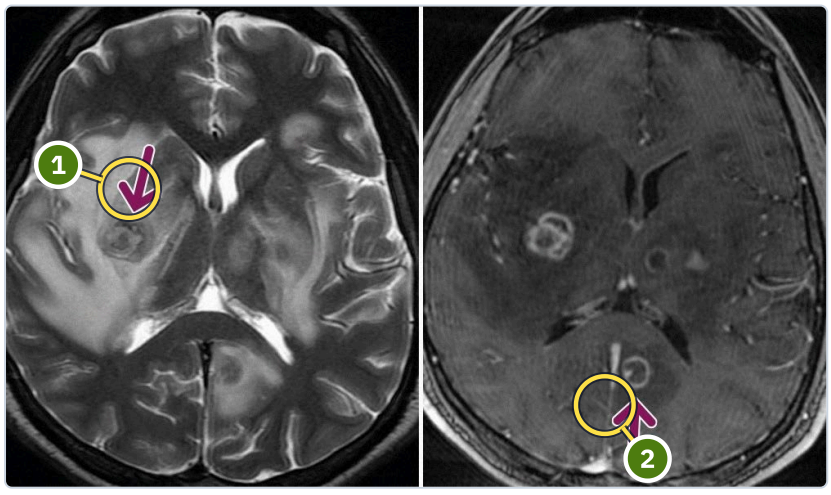



Imagen: Manual AMIR Infecciosas, p. 154

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Lesión en los ganglios basales (flecha)
2. Otra lesión con anillo

**DIAGNÓSTICO**

### Toxoplasmosis cerebral

*Lesiones múltiples con realce en anillo en ganglios basales en un VIH avanzado.*

**CONDUCTA INICIAL**

Prueba terapéutica con sulfadiazina + pirimetamina; profilaxis con cotrimoxazol si CD4 < 200.

1.04.1.014 Infección por virus de inmunodeficiencia humana (SIDA)

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Linfoma primario del SNC: lesión única que no responde al tratamiento.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA p. 43 Tema 3.2

Clase 3.2 en video

## 17 TEMA 3.3 · TUBERCULOSIS

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Manual CTO Infecciosas 14.ª ed., p. 66

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Micronódulos difusos en ambos pulmones

**DIAGNÓSTICO**

### Tuberculosis miliar

*Innumerables nódulos finos en ambos pulmones por siembra hematógena.*

**CONDUCTA INICIAL**

GeneXpert y cultivos; esquema RHZE 2 meses + RH 4 meses.

`1.04.1.028` **Tuberculosis extrapulmonar**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

`1.05.1.036` **Tuberculosis pulmonar**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Metástasis: nódulos de distinto tamaño.

**PREGUNTA REAL** **Julio 2025 · P21** «Paciente de 35 años VIH (+) con tos productiva de 3 semanas, baja de peso y sudoración nocturna. Baciloscopia de esputo positiva. ¿Cuál es el…» → **Isoniazida + Rifampicina + Pirazinamida + Etambutol por 2 meses, luego Isoniazida + Rifampicina por** …

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 47** Tema 3.3

**Clase 3.3** en video

## 18 TEMA 3.3 · TUBERCULOSIS

IMAGEN RADIOLÓGICA

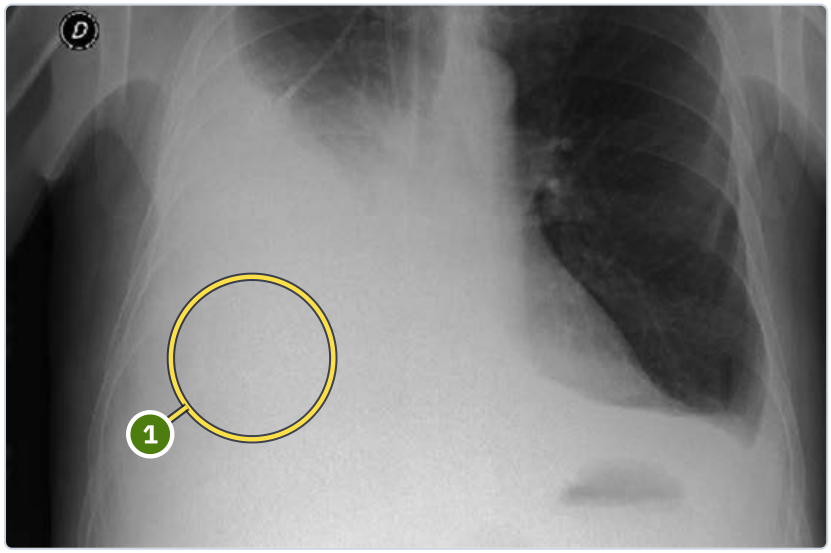



Imagen: Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 111

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Derrame que ocupa la base del hemitórax

**DIAGNÓSTICO**

### Pleuritis tuberculosa: derrame unilateral

*Exudado linfocítico unilateral con ADA > 40 UI/L.*

**CONDUCTA INICIAL**

Toracocentesis: exudado con linfocitos > 80% y ADA > 40 confirma; esquema primario.

`1.05.1.013` **Derrame pleural por tuberculosis**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Derrame paraneumónico: predominio neutrofílico.

**PREGUNTA REAL** *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 47** Tema 3.3

**Clase 3.3** en video

## 19 TEMA 3.3 · TUBERCULOSIS

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual CTO de Medicina y Cirugía, Infectología, 14.ª ed., p. 69

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Adenopatía cervical con fistulización

**DIAGNÓSTICO**

### Escrófula (adenitis tuberculosa)

*Masas cervicales indoloras y frías que coalescen y fistulizan a la piel.*

**CONDUCTA INICIAL**

Biopsia o punción para cultivo y GeneXpert; esquema antituberculoso.

| | | |
|---|---|---|
| 1.04.1.028 | Tuberculosis extrapulmonar | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Adenitis bacteriana: caliente, roja y dolorosa.

PREGUNTA REAL

**Julio 2013 · P71** «Un paciente de 35 años, sin antecedentes, con cuadro de una semana de compromiso del estado general y sensación febril, que durante los últimos…» →
**Mycobacterium tuberculosis**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 47** Tema 3.3

Clase 3.3 en video

## 20 TEMA 3.3 · TUBERCULOSIS

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA




Imagen: Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27.ª ed., p. 263

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Bacilos rojos (BAAR)

**DIAGNÓSTICO**

### Baciloscopía: tinción de Ziehl-Neelsen

*Bacilos ácido-alcohol resistentes rojos sobre fondo azul.*

**CONDUCTA INICIAL**

Baciloscopía y cultivo; GeneXpert detecta resistencia a rifampicina.

| | | |
|---|---|---|
| 1.05.1.036 | Tuberculosis pulmonar | Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo |
| 1.04.1.028 | Tuberculosis extrapulmonar | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Una baciloscopía negativa no descarta TBC.

PREGUNTA REAL

*Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 47** Tema 3.3

Clase 3.3 en video

## 21 TEMA 3.4 · INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) I

FOTO CLÍNICA

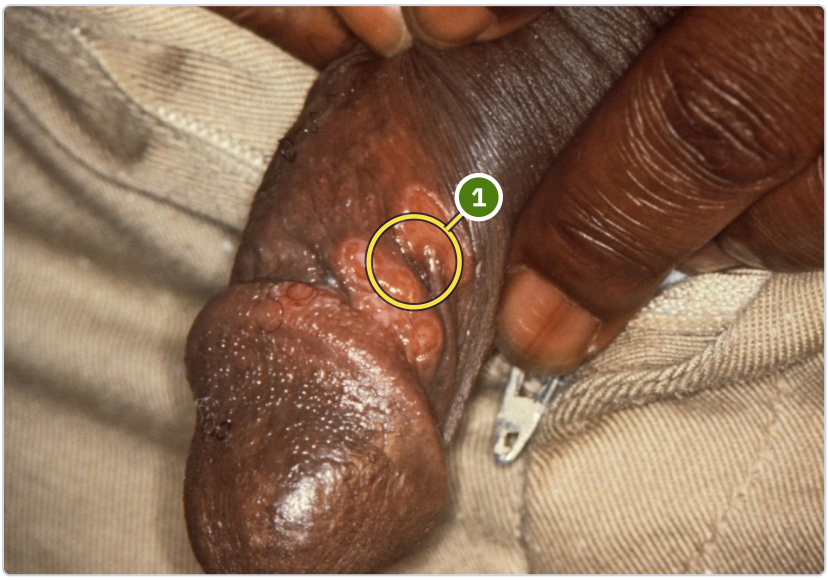



Imagen: CDC PHIL 6803 (CDC/M. Rein), dominio público

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Úlcera de fondo limpio

**DIAGNÓSTICO**

### Chancro sifilítico

*Úlcera única, indurada, de fondo limpio y sobre todo indolora.*

**CONDUCTA INICIAL**

Penicilina benzatina 2,4 MU IM en dosis única; VDRL y pareja.

| | |
|---|---|
| 1.04.1.010 | Enfermedades de transmisión sexual — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo |
| 1.04.4.016 | Serología de enfermedades infecciosas — examen/procedimiento |

**SE CONFUNDE CON…**

Herpes genital y chancroide: duelen.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2019 · P5** «Un paciente de 26 años consulta por aparición de una lesión en los genitales. Tiene antecedente de relaciones sexuales de riesgo, con múltiples…» → **VDRL**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 51** Tema 3.4

**Clase 3.4** en video

## 22 TEMA 3.4 · INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) I

FOTO CLÍNICA

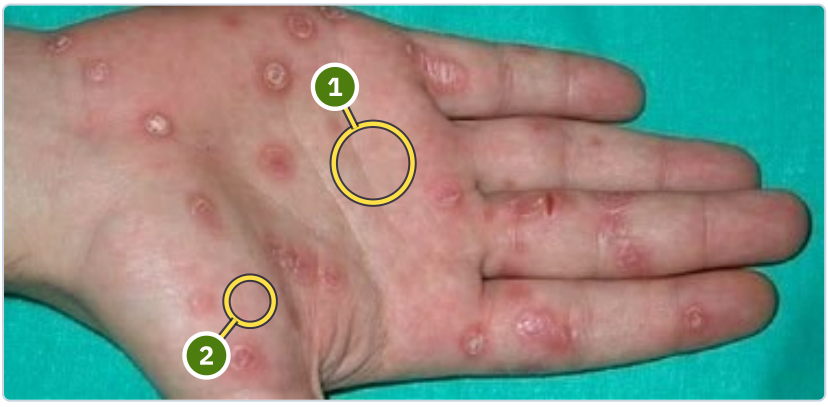



Imagen: Manual CTO de Medicina y Cirugía, Infectología, 14.ª ed., p. 99

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Máculas y pápulas en la palma
2. Collarete de descamación

**DIAGNÓSTICO**

### Sífilis secundaria palmar

*Exantema maculopapular con compromiso palmoplantar (roséola sifilítica).*

**CONDUCTA INICIAL**

Sífilis precoz: penicilina benzatina 2,4 MU IM dosis única.

| | |
|---|---|
| 1.04.1.023 | Sífilis secundaria, terciaria y congénita — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Pocos exantemas tocan palmas y plantas: el dato lleva a la sífilis.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2017 · P62** «Un paciente es diagnosticado de infección por VIH, hace 3 meses. Está en etapa A3 e inició tratamiento con triterapia antirretroviral al momento…» → **Sífilis secundaria**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 51** Tema 3.4

**Clase 3.4** en video

## 23 TEMA 3.4 · INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) I

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual CTO Infecciosas 14.ª ed., p. 99

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Placa húmeda perianal

**DIAGNÓSTICO**

### Condilomas planos

*Placas húmedas perianales muy contagiosas de la sífilis secundaria.*

**CONDUCTA INICIAL**

Penicilina benzatina; VDRL cuantitativo para seguir la respuesta.

1.04.1.023 **Sífilis secundaria, terciaria y congénita**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Condilomas acuminados (VPH): exofíticos en cresta de gallo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 51** Tema 3.4

Clase 3.4 en video

## 24 TEMA 3.4 · INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) I

FOTO CLÍNICA

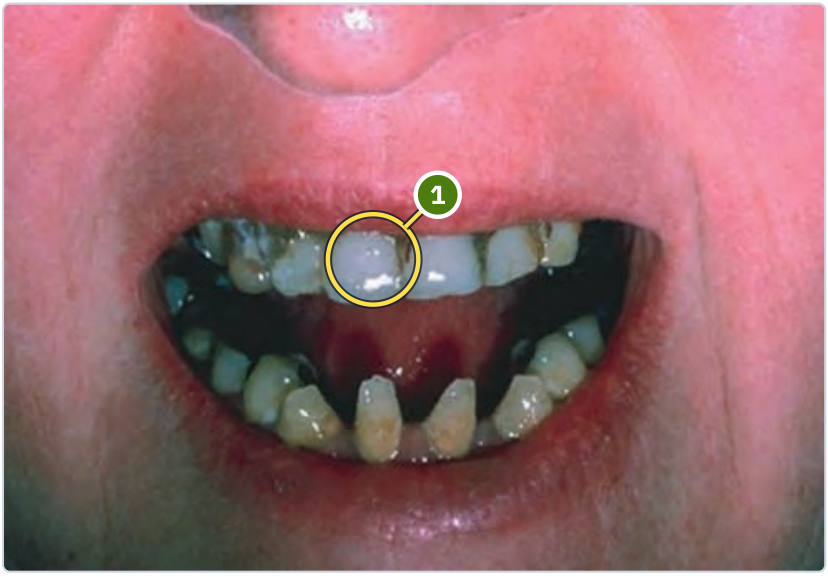



Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 207

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Incisivos con muesca en el borde

**DIAGNÓSTICO**

### Dientes de Hutchinson

*Incisivos pequeños con muesca en el borde: sífilis congénita tardía.*

**CONDUCTA INICIAL**

Tríada de Hutchinson: dientes, queratitis intersticial y sordera.

1.04.1.023 **Sífilis secundaria, terciaria y congénita**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

6.01.2.012 **Sífilis congénita**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Hipoplasia del esmalte por otras causas: sin la tríada.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 51** Tema 3.4

Clase 3.4 en video

## 25 TEMA 3.5 · INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) II

FOTO CLÍNICA

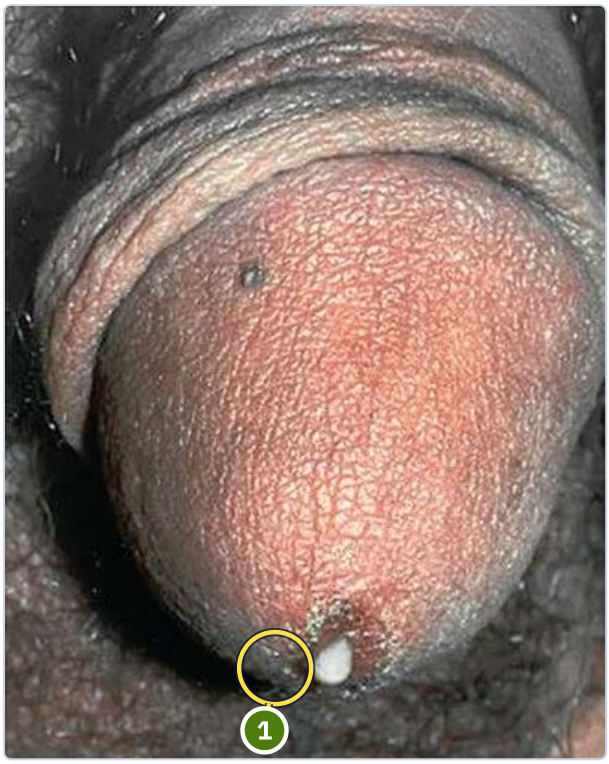



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 1602

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Gota de pus en el meato

**DIAGNÓSTICO**

### Uretritis gonocócica

*Secreción uretral abundante, espesa y purulenta con incubación corta.*

**CONDUCTA INICIAL**

Tratamiento combinado: ceftriaxona 500 mg IM + doxiciclina 7 días.

1.04.1.010 Enfermedades de transmisión sexual

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Uretritis por clamidia: secreción escasa y serosa.

PREGUNTA REAL

**Julio 2025 · P36** «Hombre de 25 años con secreción uretral purulenta y disuria de 4 días de evolución. Tinción de Gram: diplococos gram negativos intracelulares….» → **Ceftriaxona 500 mg IM dosis única**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 55** Tema 3.5

Clase 3.5 en video

## 26 TEMA 3.5 · INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) II

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 15

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Vesículas y erosiones agrupadas

**DIAGNÓSTICO**

### Herpes genital

*Vesículas agrupadas en racimo sobre base eritematosa que dejan úlceras dolorosas.*

**CONDUCTA INICIAL**

Aciclovir oral.

1.04.1.010 Enfermedades de transmisión sexual

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Chancro: único e indoloro.

PREGUNTA REAL

*Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 55** Tema 3.5

Clase 3.5 en video

## 27 TEMA 4.1 · SÍNDROME PULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)

IMAGEN RADIOLÓGICA

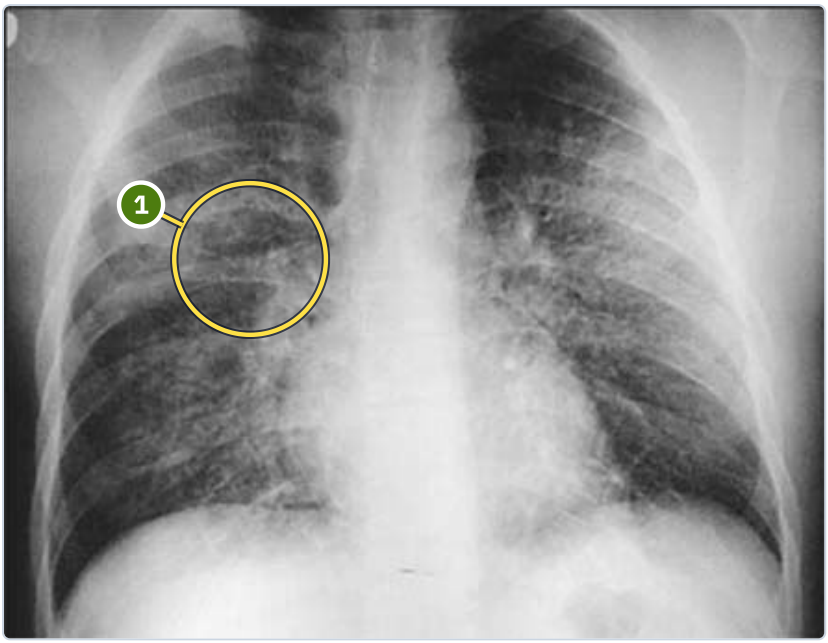



Imagen: Guía Clínica Hantavirus MINSAL 2009, Fig. 7

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Infiltrado intersticial bilateral

**DIAGNÓSTICO**

### Hantavirus: edema intersticial inicial

*Fase cardiopulmonar: edema intersticial bilateral con corazón normal.*

**CONDUCTA INICIAL**

Restricción de fluidos, UCI y ECMO de rescate; notificación inmediata.

1.04.2.008 **Síndrome pulmonar por Hanta Virus**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Neumonía atípica: sin trombocitopenia ni hemoconcentración.

PREGUNTA REAL

**Julio 2025 · P7** «Paciente de 28 años llega a urgencias con fiebre alta, cefalea intensa, mialgias, compromiso respiratorio progresivo y antecedente de trabajo en…» → **Hantavirus (Sin Nombre)**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 62** Tema 4.1

**Clase 4.1** en video

## 28 TEMA 4.1 · SÍNDROME PULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)

IMAGEN RADIOLÓGICA

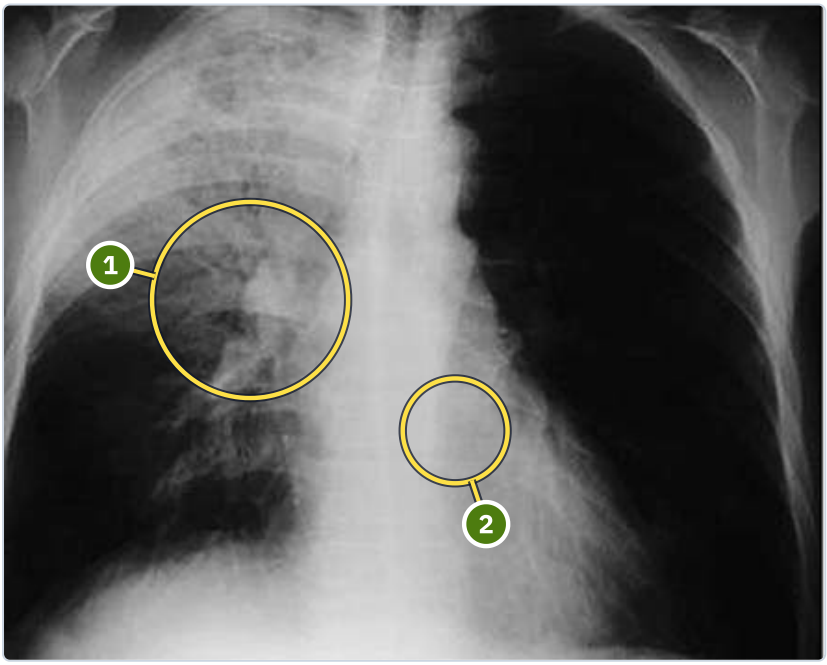



Imagen: Guía Clínica Hantavirus MINSAL 2009 (Rev Chil Infect 26:68), Fig. 11

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Opacidad extensa bilateral
2. Silueta cardíaca normal

**DIAGNÓSTICO**

### Hantavirus: edema pulmonar extenso

*Horas después: edema pulmonar extenso por fuga capilar, con corazón de tamaño normal.*

**CONDUCTA INICIAL**

Manejo restrictivo de fluidos para no inundar el alvéolo; ECMO veno-arterial.

1.04.2.008 **Síndrome pulmonar por Hanta Virus**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Edema cardiogénico: cardiomegalia.

PREGUNTA REAL

**Julio 2025 · P7** «Paciente de 28 años llega a urgencias con fiebre alta, cefalea intensa, mialgias, compromiso respiratorio progresivo y antecedente de trabajo en…» → **Hantavirus (Sin Nombre)**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 62** Tema 4.1

**Clase 4.1** en video

## 29 TEMA 4.2 · ENFERMEDAD DE CHAGAS

OTRA (AGENTE O VECTOR)

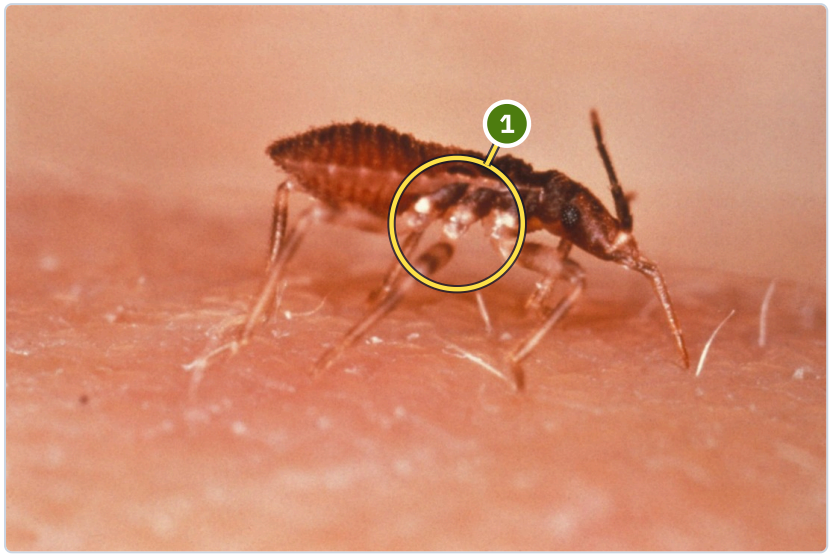



Imagen: Wikimedia Commons, dominio público

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Insecto hematófago (triatomino)

**DIAGNÓSTICO**

### Vinchuca (Triatoma infestans)

*Vector clásico del Chagas; la transmisión domiciliaria se interrumpió en 1999.*

**CONDUCTA INICIAL**

Hoy la vía más frecuente en Chile es la vertical: tamizaje prenatal con serología.

1.04.4.016 **Serología de enfermedades infecciosas**
examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

Hoy la vinchuca ya no es la vía más frecuente en Chile: es la vertical.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 66** Tema 4.2

Clase 4.2 en video

## 30 TEMA 4.2 · ENFERMEDAD DE CHAGAS

FOTO CLÍNICA




Imagen: CDC, CC0

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Edema palpebral unilateral

**DIAGNÓSTICO**

### Signo de Romaña

*Edema bipalpebral indoloro de un solo ojo con adenopatía preauricular: Chagas agudo.*

**CONDUCTA INICIAL**

Fase aguda: diagnóstico parasitológico directo o PCR; nifurtimox o benznidazol 60 días.

1.04.4.016 **Serología de enfermedades infecciosas**
examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

Celulitis periorbitaria: dolorosa, con fiebre.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 66** Tema 4.2

Clase 4.2 en video

**31** TEMA 4.2 · ENFERMEDAD DE CHAGAS — TRAZADO (ECG / REGISTRO)

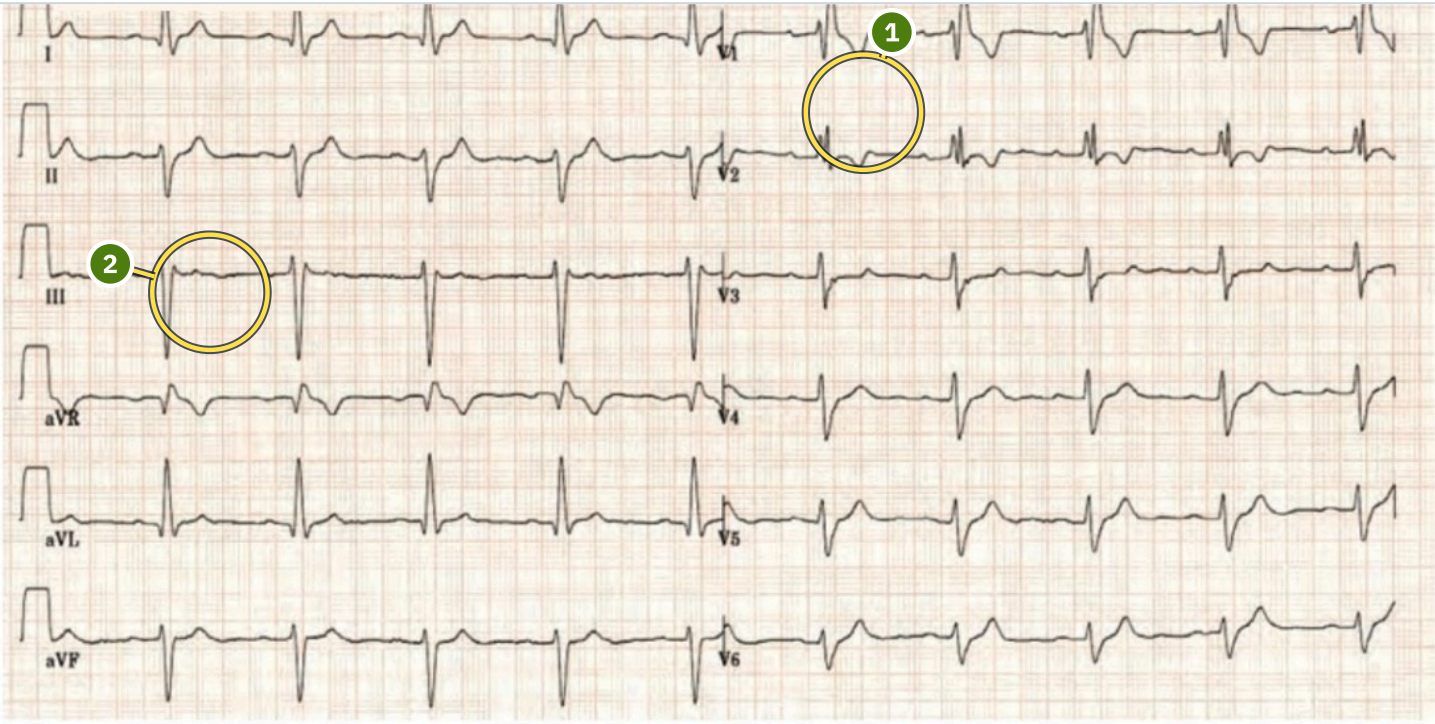



Imagen: ECG from Basics to Essentials, p. 119

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. rSR' en V1 (bloqueo de rama derecha)
2. Eje izquierdo: DII, DIII y aVF negativos

**DIAGNÓSTICO**

## Cardiopatía chagásica: BCRD + HBAI

*Bloqueo completo de rama derecha con hemibloqueo anterior izquierdo.*

**CONDUCTA INICIAL**

En un paciente del norte con esta combinación, pedir serología (ELISA + IFI).

| | | |
|---|---|---|
| 1.01.1.020 | Miocardiopatías | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 1.04.4.016 | Serología de enfermedades infecciosas | examen/procedimiento |

**SE CONFUNDE CON…**

BCRD aislado: sin desviación del eje.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA p. 66 Tema 4.2

Clase 4.2 en video

## 32 TEMA 4.3 · ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual CTO Infecciosas 14.ª ed., p. 134

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Islas de piel sana dentro del eritema

**DIAGNÓSTICO**

### Exantema del dengue

*Exantema eritematoso con islas de piel sana («islas blancas en un mar rojo»).*

**CONDUCTA INICIAL**

Solo paracetamol: AINE y aspirina contraindicados; vigilar signos de alarma.

1.04.1.008 Dengue — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Sarampión y escarlatina: sin islas blancas.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA p. 70 Tema 4.3

Clase 4.3 en video

## 33 TEMA 4.3 · ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

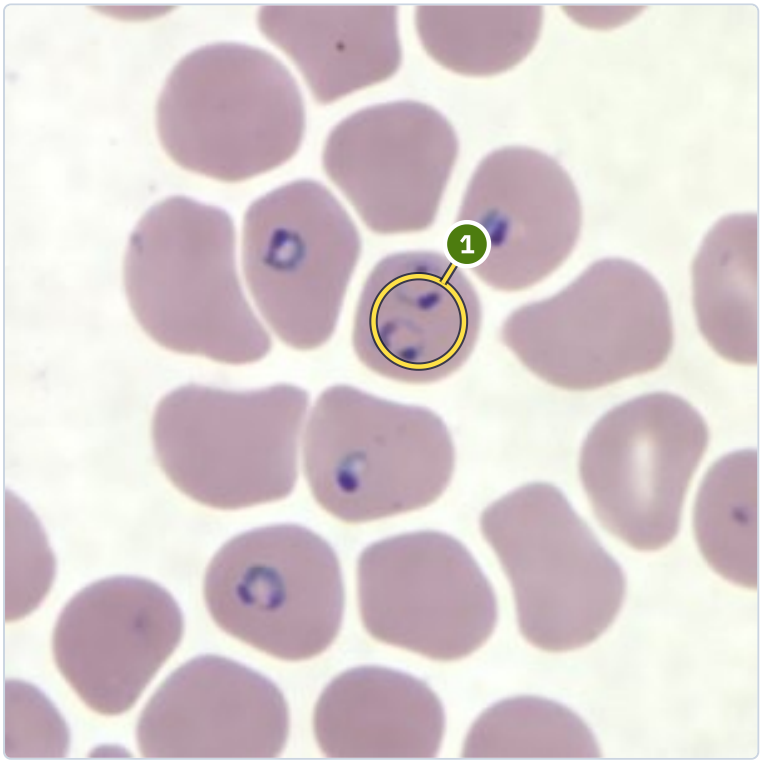



Imagen: CDC DPDx, dominio público

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Trofozoíto en anillo intraeritrocitario

**DIAGNÓSTICO**

### Malaria: trofozoítos en anillo

*Gota gruesa y frotis con Giemsa: anillos dentro del glóbulo rojo.*

**CONDUCTA INICIAL**

Gota gruesa es el diagnóstico de certeza; cuantificar la parasitemia.

1.04.1.018 Malaria — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Plaquetas superpuestas al eritrocito.

PREGUNTA REAL **Julio 2019 · P147** «Una paciente realiza un viaje a la selva amazónica y, al cuarto día luego de su regreso, presenta fiebre alta hasta 39,3°C, asociada a cefalea…» → **Plasmodium falciparum**

TOMO INFECTOLOGÍA p. 70 Tema 4.3

Clase 4.3 en video

## 34 TEMA 4.3 · ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

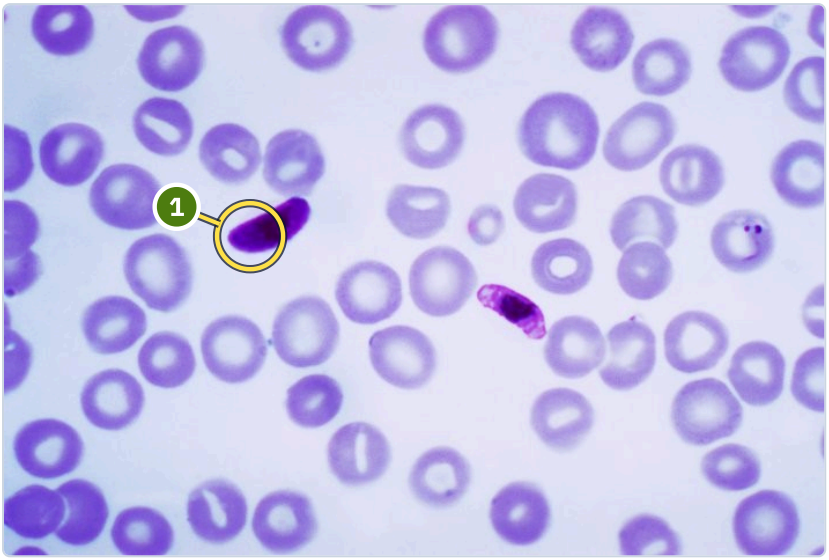



Imagen: CDC (Commons "Plasmodium falciparum 01"), dominio público

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Gametocito en banana

**DIAGNÓSTICO**

### Gametocitos en banana (P. falciparum)

*Gametocitos en forma de banana, exclusivos de falciparum, la especie grave.*

**CONDUCTA INICIAL**

Terapia combinada con artemisinina (arteméter-lumefantrina).

1.04.1.018 Malaria

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

P. vivax: requiere primaquina para los hipnozoítos.

PREGUNTA REAL **Julio 2019 · P147** «Una paciente realiza un viaje a la selva amazónica y, al cuarto día luego de su regreso, presenta fiebre alta hasta 39,3°C, asociada a cefalea…» → **Plasmodium falciparum**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 70** Tema 4.3

Clase 4.3 en video

## 35 TEMA 4.4 · ZOONOSIS CHILENAS ENDÉMICAS

ECOGRAFÍA

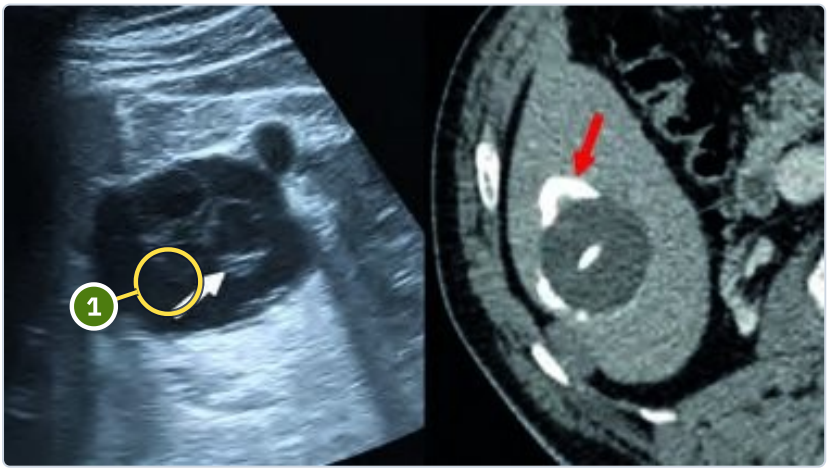



Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 43

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Vesículas hijas (flecha)

**DIAGNÓSTICO**

### Quiste hidatídico hepático: vesículas hijas

*Vesículas hijas dentro del quiste (imagen en rueda de carreta).*

**CONDUCTA INICIAL**

Ecografía abdominal y serología; albendazol y cirugía o PAIR según el estadio.

1.04.1.013 Hidatidosis

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Quiste simple: anecoico sin tabiques.

PREGUNTA REAL **Julio 2016 · P72** «Un hombre de 40 años presenta un cuadro de dolor abdominal, de 3 meses de evolución, leve, intermitente. Al examen físico presenta leve dolor a…» → **Serología para hidatidosis**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 74** Tema 4.4

Clase 4.4 en video

## 36 TEMA 4.4 · ZOONOSIS CHILENAS ENDÉMICAS

IMAGEN RADIOLÓGICA

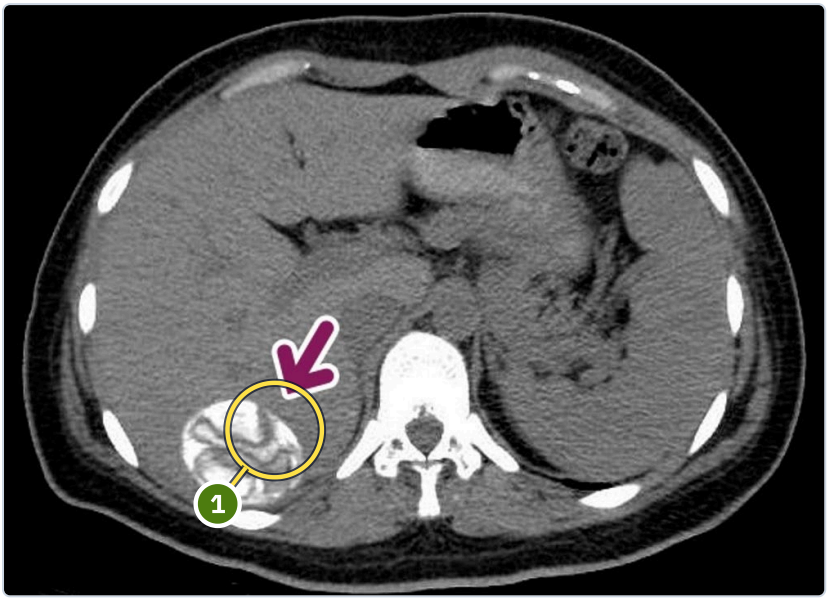



Imagen: Manual AMIR Infecciosas, p. 189

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Membranas desprendidas en el quiste (flecha)

**DIAGNÓSTICO**

### Quiste hidatídico: signo del camalote

*Membrana germinativa desprendida flotando dentro del quiste.*

**CONDUCTA INICIAL**

Camalote = hidatidosis; no puncionar a ciegas (riesgo de anafilaxia).

1.04.1.013 Hidatidosis — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Absceso hepático: fiebre, pared gruesa sin membranas.

PREGUNTA REAL **Julio 2016 · P72** «Un hombre de 40 años presenta un cuadro de dolor abdominal, de 3 meses de evolución, leve, intermitente. Al examen físico presenta leve dolor a...» → **Serología para hidatidosis**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 74** Tema 4.4

Clase 4.4 en video

## 37 TEMA 4.4 · ZOONOSIS CHILENAS ENDÉMICAS

IMAGEN RADIOLÓGICA

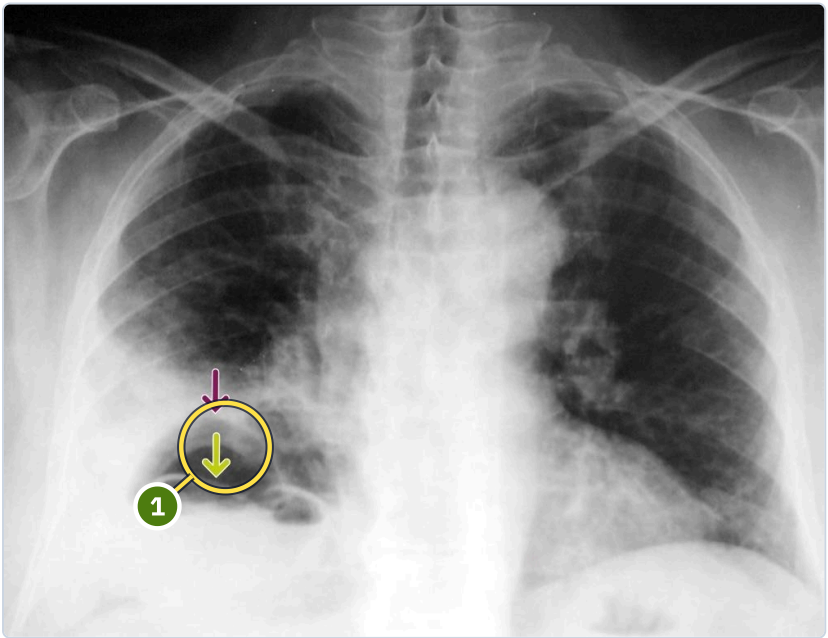



Imagen: Manual AMIR Infecciosas, p. 189

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Imagen redonda de bordes nítidos (flechas)

**DIAGNÓSTICO**

### Quiste hidatídico pulmonar

*Imagen redonda, homogénea y de bordes nítidos.*

**CONDUCTA INICIAL**

Radiografía de tórax y cirugía; albendazol.

1.05.1.020 Hidatidosis pulmonar — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.04.1.013 Hidatidosis — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Nódulo tumoral: bordes irregulares.

PREGUNTA REAL **Enero 2023 · P88** «Paciente con expectoración hemoptoica y eliminación de contenido 'en uvas'. Radiografía con imagen compatible. ¿Diagnóstico más probable?» → **Quiste hidatídico pulmonar**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 74** Tema 4.4

Clase 4.4 en video

## 38 TEMA 4.5 · BACTERIOSIS ZOONÓTICAS

FOTO CLÍNICA

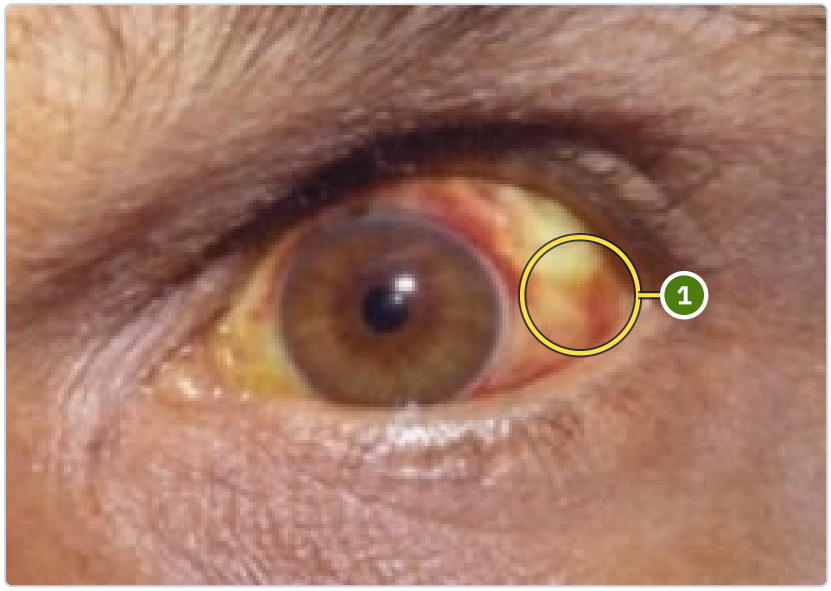



Imagen: Wikimedia Commons, CC BY 4.0

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Conjuntiva roja sin pus

**DIAGNÓSTICO**

### Leptospirosis: sufusión conjuntival

*Ojo rojo bilateral sin secreción y dolor en las pantorrillas tras agua contaminada.*

**CONDUCTA INICIAL**

Síndrome de Weil (ictericia, falla renal, hemorragia pulmonar): penicilina G o ceftriaxona EV.

1.04.1.017 **Leptospirosis**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Conjuntivitis: con secreción.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 78** Tema 4.5

**Clase 4.5** en video

## 39 TEMA 4.5 · BACTERIOSIS ZOONÓTICAS

FOTO CLÍNICA




Imagen: CDC PHIL 2215 (CDC/Armed Forces Institute of Pathology), dominio público

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Máculas rosadas tenues en el tronco

**DIAGNÓSTICO**

### Fiebre tifoidea: roséola tífica

*Manchas rosadas en el abdomen y tórax durante la segunda semana.*

**CONDUCTA INICIAL**

Hemocultivo; ceftriaxona de elección.

1.04.1.012 **Fiebre tifoídea y paratifoídea**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

2.01.1.013 **Infecciones por Salmonella**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Exantema viral: sin fiebre prolongada ni bradicardia relativa.

PREGUNTA REAL **Enero 2023 · P23** «Niño con fiebre de 10 días, cefalea, mialgias, diarrea y luego heces duras, hígado y bazo palpables. ¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar…» → **Hemocultivo**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 78** Tema 4.5

**Clase 4.5** en video

## 40 TEMA 4.6 · ÁNTRAX (CARBUNCO CUTÁNEO Y RESPIRATORIO)

FOTO CLÍNICA

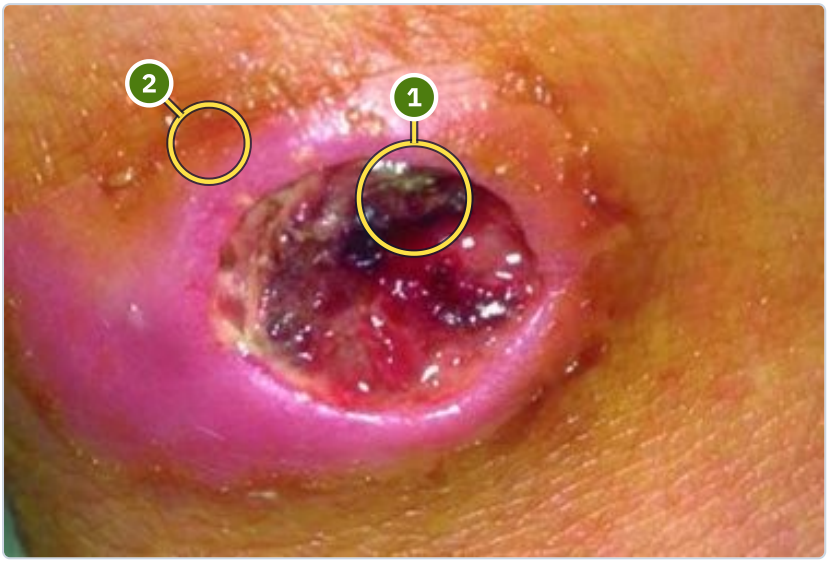



Imagen: Manual CTO Infecciosas 14.ª ed., p. 105

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Escara negra central
2. Corona de vesículas y edema

**DIAGNÓSTICO**

### Carbunco cutáneo (pústula maligna)

*Escara negra central rodeada de vesículas y edema, indolora y sin pus.*

**CONDUCTA INICIAL**

Ciprofloxacino o doxiciclina 60 días; NO desbridar.

| | | |
|---|---|---|
| 1.04.1.003 | Ántrax | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 6.01.2.002 | Ántrax | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Loxoscelismo y ectima gangrenoso: dolorosos.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 81** Tema 4.6

**Clase 4.6** en video

## 41 TEMA 4.6 · ÁNTRAX (CARBUNCO CUTÁNEO Y RESPIRATORIO)

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Atlas EUNACOM 2026

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Mediastino ensanchado

**DIAGNÓSTICO**

### Carbunco inhalatorio: mediastino ensanchado

*Ensanchamiento marcado del mediastino por mediastinitis hemorrágica.*

**CONDUCTA INICIAL**

Cuadro gripal fulminante con mediastino ancho: carbunco por inhalación.

| | | |
|---|---|---|
| 1.04.1.003 | Ántrax | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Disección aórtica: dolor desgarrante.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 81** Tema 4.6

**Clase 4.6** en video

## 42 TEMA 4.6 · ÁNTRAX (CARBUNCO CUTÁNEO Y RESPIRATORIO)

FOTO CLÍNICA




Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 798

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Placa livedoide con necrosis

**DIAGNÓSTICO**

### Loxoscelismo cutáneo

*Placa livedoide violácea con necrosis, intensamente dolorosa y quemante.*

**CONDUCTA INICIAL**

El dolor lo separa del carbunco (indoloro).

1.04.1.003 Ántrax

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Carbunco cutáneo: escara indolora.

PREGUNTA REAL

*Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA p. 81 Tema 4.6

Clase 4.6 en video

## 43 TEMA 4.6 · ÁNTRAX (CARBUNCO CUTÁNEO Y RESPIRATORIO)

FOTO CLÍNICA

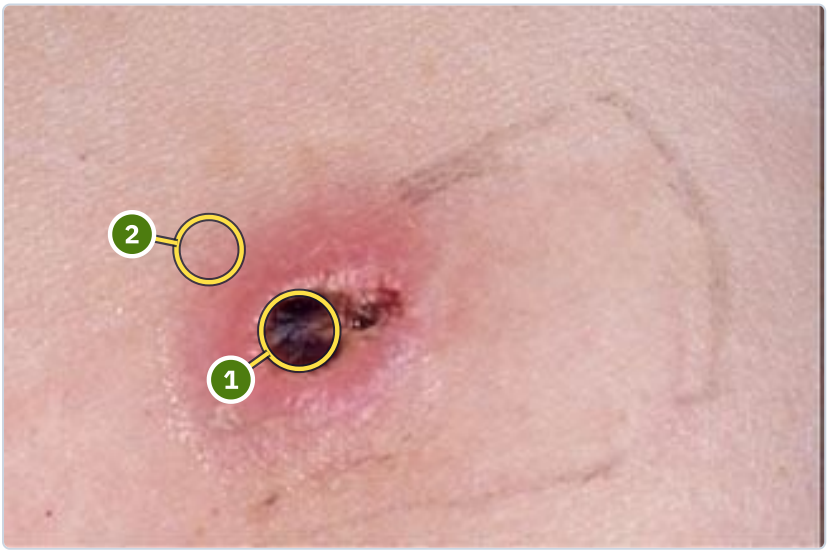



Imagen: Atlas EUNACOM 2026

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Úlcera necrótica central
2. Halo eritematoso

**DIAGNÓSTICO**

### Ectima gangrenoso (Pseudomonas)

*Úlcera necrótica con halo eritematoso en un paciente neutropénico.*

**CONDUCTA INICIAL**

Neutropenia febril: antibiótico con cobertura antipseudomona (cefepime) en < 60 minutos.

1.04.1.020 Neutropenia febril

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Carbunco cutáneo: indoloro, sin neutropenia.

PREGUNTA REAL

**Diciembre 2022 · P45** «Una paciente de 35 años, consulta por dolor de en la zona escapular izquierda, que comenzó hace un día. Además, notó la aparición de una lesión…» → **Pseudomona aureginosa**

TOMO INFECTOLOGÍA p. 81 Tema 4.6

Clase 4.6 en video

## 44 TEMA 5.1 · INFECCIONES DE PIEL COMUNITARIAS

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 25

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Borde nítido y sobreelevado

**DIAGNÓSTICO**

### Erisipela

*Placa rojo vivo, sobreelevada, con borde nítido como un escalón.*

**CONDUCTA INICIAL**

Marcar los bordes y cefadroxilo (o flucloxacilina) 7-10 días; buscar la puerta de entrada.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.01.2.003 | Erisipela / Celulitis | Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo |
| 1.04.1.006 | Celulitis bacteriana | Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo |

**SE CONFUNDE CON…**

Celulitis: bordes difusos, más profunda.

PREGUNTA REAL

**Diciembre 2019 · P137** «Una paciente de 62 años presenta una caída a nivel, con erosión en la rodilla derecha. Tres días después presenta una lesión eritematosa, que…» → **Indicar cefadroxilo oral por 7 días**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 89** Tema 5.1

**Clase 5.1** en video

## 45 TEMA 5.1 · INFECCIONES DE PIEL COMUNITARIAS

FOTO CLÍNICA

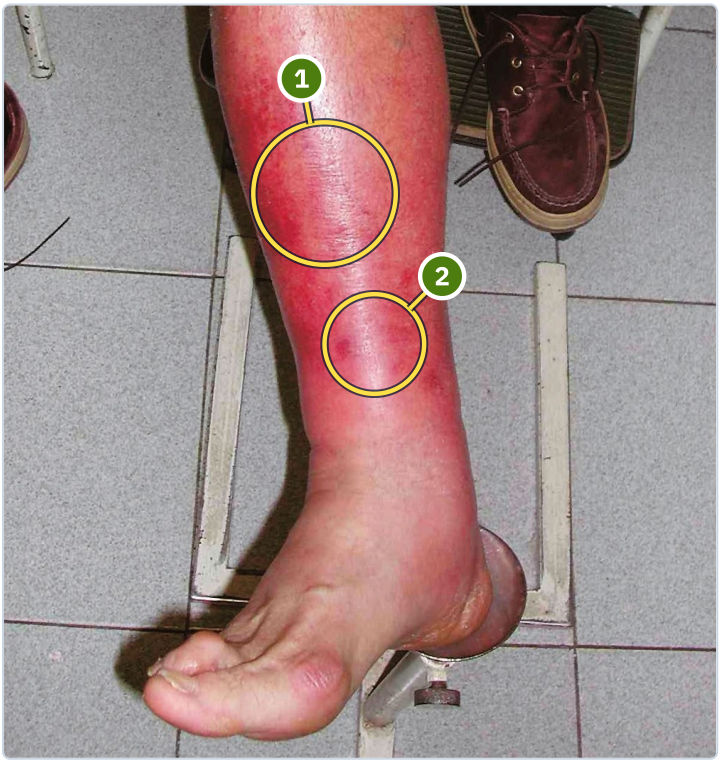



Imagen: Manual AMIR Infecciosas, p. 67

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Eritema difuso de la pierna
2. Bordes mal delimitados

**DIAGNÓSTICO**

### Celulitis

*Eritema de bordes difusos y mal delimitados, sin relieve.*

**CONDUCTA INICIAL**

Cefadroxilo oral 7-10 días; tinea pedis interdigital como puerta de entrada.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.04.1.006 | Celulitis bacteriana | Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo |
| 6.01.2.003 | Erisipela / Celulitis | Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo |

**SE CONFUNDE CON…**

TVP: edema sin placa eritematosa caliente.

PREGUNTA REAL

**Julio 2017 · P106** «Una paciente de 30 años presenta una caída, con erosión de la rodilla derecha. Us- ted la evalúa 3 días después, observándose una zona…» → **Cefadroxilo oral por 7 días**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 89** Tema 5.1

**Clase 5.1** en video

## 46 TEMA 5.1 · INFECCIONES DE PIEL COMUNITARIAS

FOTO CLÍNICA




Imagen: Atlas EUNACOM 2026

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Pústula centrada en el folículo

**DIAGNÓSTICO**

### Foliculitis

*Pequeñas pústulas indoloras, cada una centrada en un vello.*

**CONDUCTA INICIAL**

Aseo con clorhexidina o mupirocina tópica al 2%.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.01.1.021 | Piodermias superficiales y profundas (no linfáticas) | Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo |

**SE CONFUNDE CON…**

Acné: comedones.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 89** Tema 5.1

**Clase 5.1** en video

## 47 TEMA 5.1 · INFECCIONES DE PIEL COMUNITARIAS

FOTO CLÍNICA




Imagen: Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine, p. 1739

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Placa con múltiples puntos de drenaje

**DIAGNÓSTICO**

### Ántrax estafilocócico

*Forúnculos coalescentes unidos bajo la piel, en la nuca de un diabético.*

**CONDUCTA INICIAL**

Drenaje y antibiótico antiestafilocócico; nada que ver con Bacillus anthracis.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.01.1.055 | Abscesos, forúnculos, panadizos, flegmones | Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo |
| 6.01.1.021 | Piodermias superficiales y profundas (no linfáticas) | Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo |

**SE CONFUNDE CON…**

Carbunco por B. anthracis: escara negra indolora.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2024 · P174** «Un paciente consulta por un forúnculo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?» → **Drenaje**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 89** Tema 5.1

**Clase 5.1** en video

## 48 TEMA 5.2 · SÍNDROME MONONUCLEÓSICO Y COMPLEJO TORCH

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

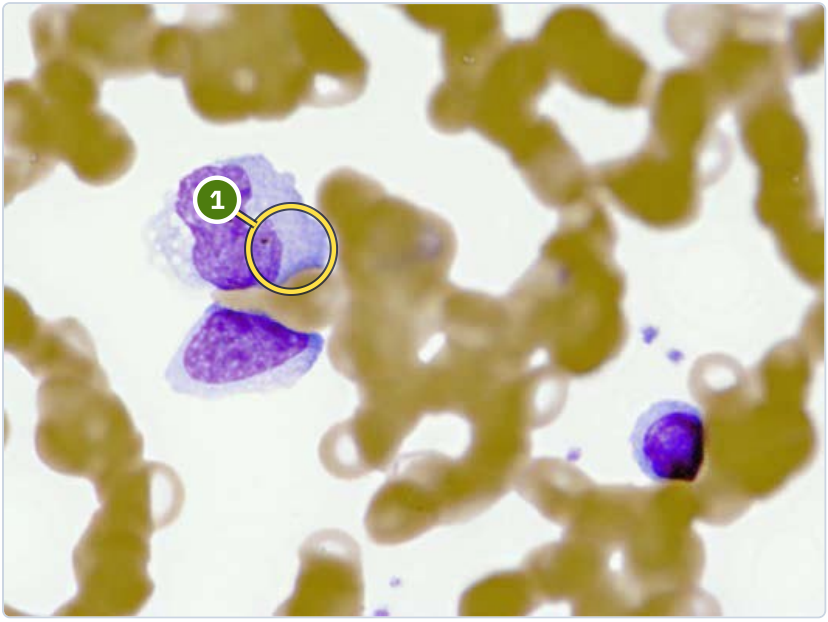



Imagen: Atlas EUNACOM 2026

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Linfocito atípico

**DIAGNÓSTICO**

### Linfocitos atípicos (de Downey)

*Células grandes de citoplasma abundante y basófilo: > 10% en la mononucleosis.*

**CONDUCTA INICIAL**

Heterófilos o IgM anti-VCA; sin deportes de contacto 3-4 semanas.

| | | |
|---|---|---|
| 1.04.1.025 | Síndrome mononucleósico | Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo |
| 1.04.4.010 | Hemograma y velocidad de hemosedimentación (VHS) | examen/procedimiento |

**SE CONFUNDE CON…**

Blastos de leucemia: núcleo inmaduro, otras citopenias.

**PREGUNTA REAL** **Diciembre 2024 · P169** «Joven de 18 años con más de 7 días de faringitis eritematosa y adenopatías, con múltiples consultas por el cuadro. Recibió amoxicilina y presenta…» → **IgM anti cápside del virus de Epstein-Barr**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 92** Tema 5.2

Clase 5.2 en video

## 49 TEMA 5.2 · SÍNDROME MONONUCLEÓSICO Y COMPLEJO TORCH

FOTO CLÍNICA

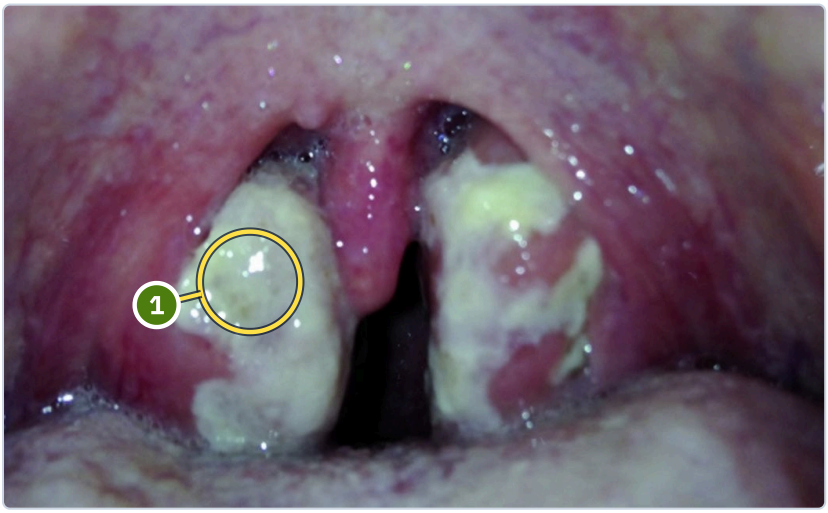



Imagen: Manual CTO Otorrinolaringología 14.ª ed., p. 71

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Amígdalas hipertróficas con exudado

**DIAGNÓSTICO**

### Amigdalitis del síndrome mononucleósico

*Faringoamigdalitis exudativa con placas blancas: indistinguible de la estreptocócica.*

**CONDUCTA INICIAL**

Faringitis + adenopatías posteriores + esplenomegalia: VEB; evitar amoxicilina.

| | | |
|---|---|---|
| 1.04.1.025 | Síndrome mononucleósico | Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo |
| 2.01.1.016 | Mononucleosis infecciosa | Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo |

**SE CONFUNDE CON…**

Faringoamigdalitis estreptocócica: misma garganta.

**PREGUNTA REAL** **Julio 2013 · P152** «Una paciente de 18 años, sin antecedentes, consulta por cuadro de 3 días de compromiso del estado general, sensación febril, coriza y odinofagia….» → **Mononucleosis por Virus Epstein Barr**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 92** Tema 5.2

Clase 5.2 en video

## 50 TEMA 5.2 · SÍNDROME MONONUCLEÓSICO Y COMPLEJO TORCH

FOTO CLÍNICA

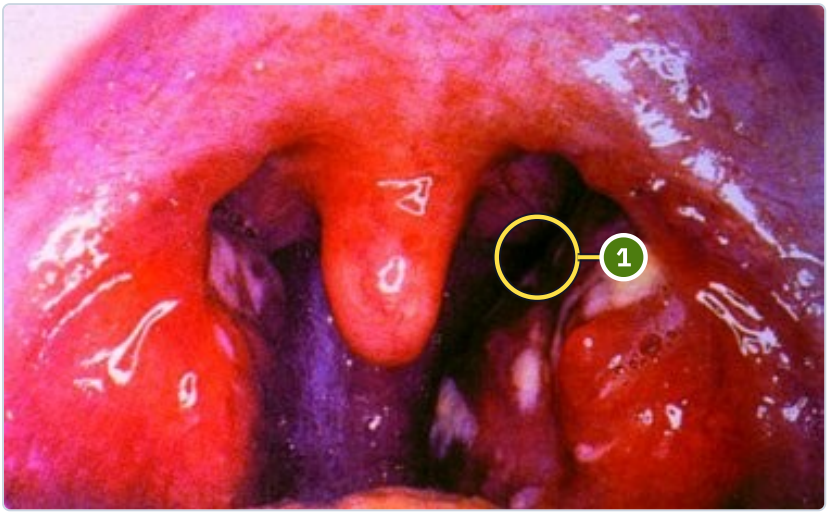



Imagen: Manual CTO Infecciosas 14.ª ed., p. 51

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Exudado amigdalino

**DIAGNÓSTICO**

### Faringoamigdalitis estreptocócica

*Amigdalitis pultácea por Streptococcus pyogenes.*

**CONDUCTA INICIAL**

Amoxicilina 10 días (o penicilina benzatina) para prevenir la fiebre reumática.

1.04.1.025 Síndrome mononucleósico

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Mononucleosis: amoxicilina da exantema en > 90%.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA p. 92 Tema 5.2

Clase 5.2 en video

## 51 TEMA 5.2 · SÍNDROME MONONUCLEÓSICO Y COMPLEJO TORCH

ECOGRAFÍA

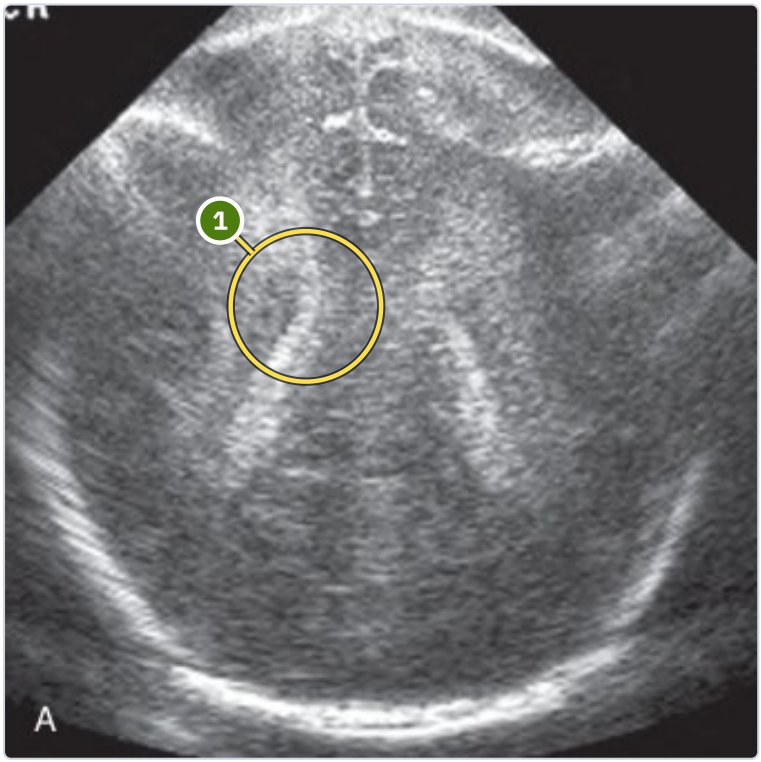



Imagen: Rumack, Diagnostic Ultrasound, 4.ª ed., p. 1621

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Calcificaciones periventriculares

**DIAGNÓSTICO**

### CMV congénito: calcificaciones periventriculares

*Calcificaciones alrededor de los ventrículos en la ecografía cerebral neonatal.*

**CONDUCTA INICIAL**

TORCH: CMV da calcificaciones periventriculares e hipoacusia.

2.01.1.127 TORCH

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Toxoplasmosis congénita: calcificaciones difusas y coriorretinitis.

PREGUNTA REAL **Julio 2025 · P18** «RN con microcefalia, calcificaciones periventriculares y coriorretinitis. Madre con serología IgG positiva para CMV y IgM positiva. ¿Cuál es el…» → **Citomegalovirus (CMV)**

TOMO INFECTOLOGÍA p. 92 Tema 5.2

Clase 5.2 en video

## 52 TEMA 5.3 · EXANTEMAS FEBRILES DE LA INFANCIA

FOTO CLÍNICA

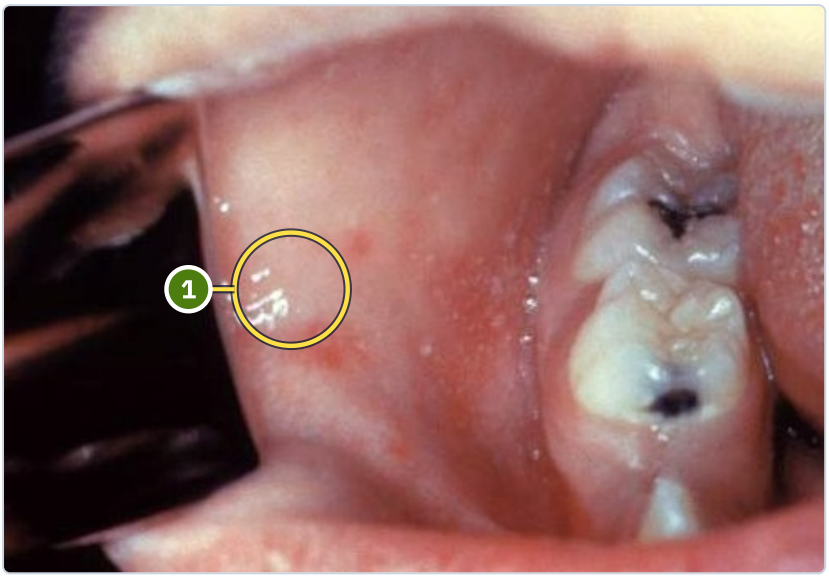



Imagen: CDC PHIL 6111, dominio público

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Puntos blancos sobre mucosa roja

**DIAGNÓSTICO**

### Manchas de Koplik

*Pápulas blanquecinas milimétricas en la mucosa yugal frente al 2.º molar.*

**CONDUCTA INICIAL**

Sarampión: notificación inmediata (ENO) y aislamiento.

2.01.1.009 Exantemas virales

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Muguet: placas que se desprenden.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA p. 97 Tema 5.3

Clase 5.3 en video

## 53 TEMA 5.3 · EXANTEMAS FEBRILES DE LA INFANCIA

FOTO CLÍNICA

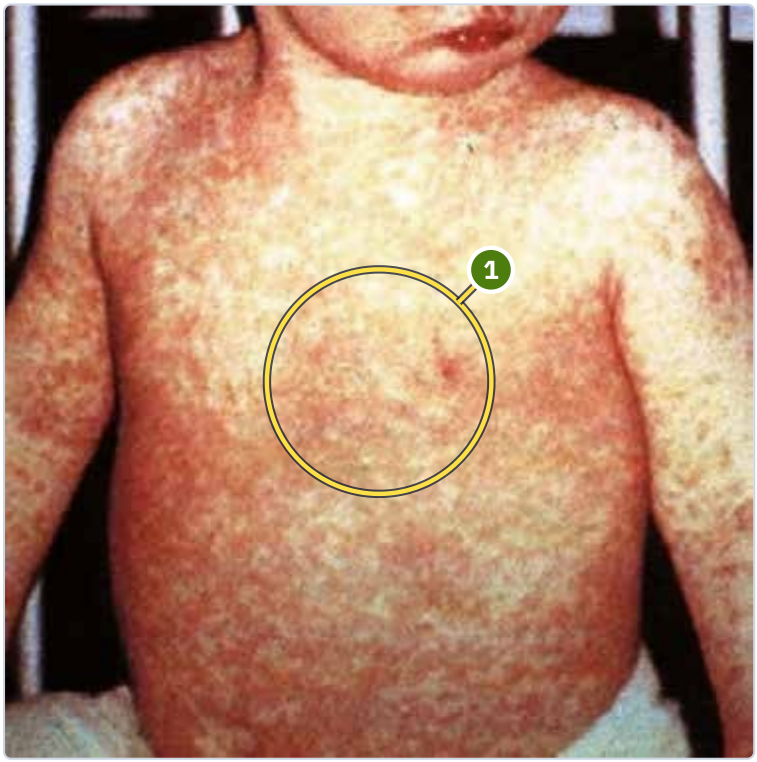



Imagen: Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 97

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Exantema maculopapular confluente

**DIAGNÓSTICO**

### Exantema del sarampión

*Exantema maculopapular confluente que parte detrás de las orejas y baja.*

**CONDUCTA INICIAL**

Notificación inmediata (ENO) y aislamiento; buscar Koplik.

2.01.1.009 Exantemas virales

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Rubéola: máculas rosadas que no confluyen.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA p. 97 Tema 5.3

Clase 5.3 en video

## 54 TEMA 5.3 · EXANTEMAS FEBRILES DE LA INFANCIA

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 98

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Máculas rosadas no confluentes

**DIAGNÓSTICO**

### Exantema de la rubéola

*Máculas rosadas que no confluyen y bajan rápido de la cabeza a los pies.*

**CONDUCTA INICIAL**

Buscar adenopatías retroauriculares y suboccipitales; notificación.

2.01.1.009 Exantemas virales — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Sarampión: exantema confluente con Koplik.

PREGUNTA REAL **Julio 2019 · P96** «Un recién nacido de 38 semanas, presenta hipotonía, dificultad a la succión y circunferencia craneana 26 cm. Al examen tiene ausencia del rojo…» → **Virus rubéola**

TOMO INFECTOLOGÍA p. 97 Tema 5.3

Clase 5.3 en video

## 55 TEMA 5.3 · EXANTEMAS FEBRILES DE LA INFANCIA

FOTO CLÍNICA

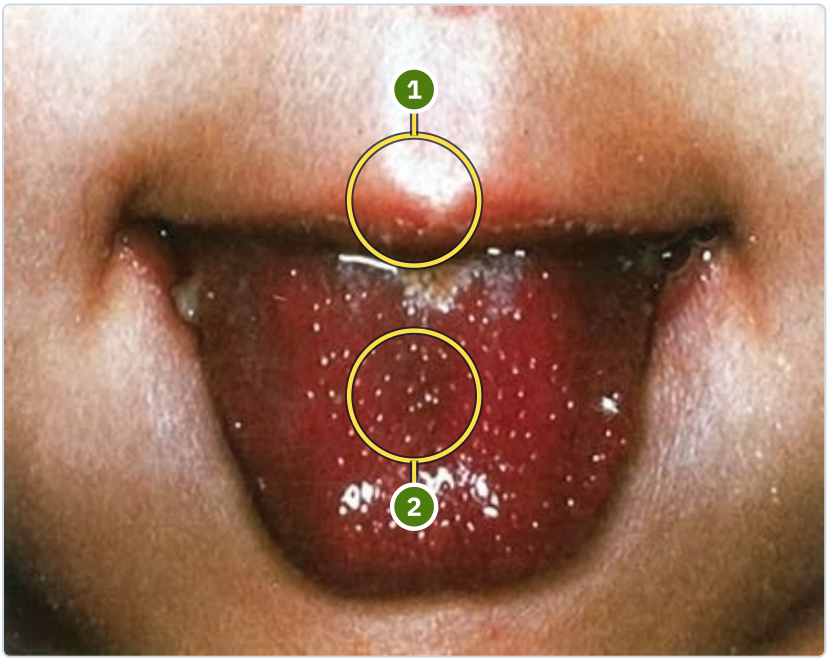



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22nd ed., p. 1967

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Labios rojos y fisurados
2. Lengua en frambuesa

**DIAGNÓSTICO**

### Kawasaki: labios fisurados y lengua en frambuesa

*Labios rojos y fisurados con lengua en frambuesa.*

**CONDUCTA INICIAL**

Fiebre ≥ 5 días + 4 criterios: IGEV 2 g/kg + aspirina; ecocardiograma.

2.01.1.058 Vasculitis: PSH, Kawasaki, otros — Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Escarlatina: también lengua en frambuesa, con exantema en lija.

PREGUNTA REAL **Julio 2025 · P11** «Niño de 8 años con fiebre de 39°C por 7 días de evolución, exantema polimorfo, adenopatías cervicales, conjuntivitis bilateral no exudativa y…» → **Enfermedad de Kawasaki**

TOMO INFECTOLOGÍA p. 98 Tema 5.3

Clase 5.3 en video

## 56 TEMA 5.3 · EXANTEMAS FEBRILES DE LA INFANCIA

FOTO CLÍNICA

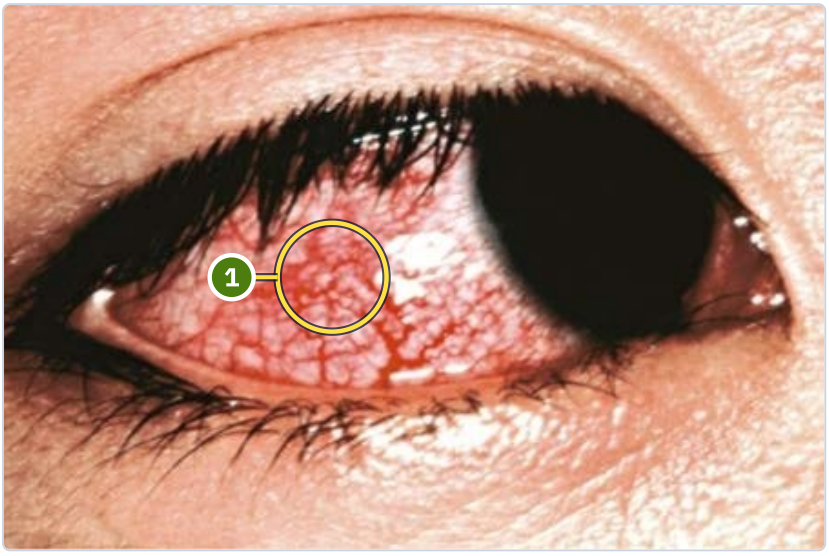



Imagen: Atlas EUNACOM 2026

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Ojo rojo seco, sin secreción

**DIAGNÓSTICO**

### Kawasaki: conjuntivitis bulbar sin pus

*Inyección conjuntival bilateral, bulbar y no exudativa.*

**CONDUCTA INICIAL**

Fiebre ≥ 5 días + 4 de 5 criterios: IGEV 2 g/kg + aspirina; ecocardiograma.

2.01.1.058 Vasculitis: PSH, Kawasaki, otros

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Conjuntivitis viral o bacteriana: con secreción.

PREGUNTA REAL **Julio 2025 · P11** «Niño de 8 años con fiebre de 39°C por 7 días de evolución, exantema polimorfo, adenopatías cervicales, conjuntivitis bilateral no exudativa y…» → **Enfermedad de Kawasaki**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 98** Tema 5.3

**Clase 5.3** en video

## 57 TEMA 5.3 · EXANTEMAS FEBRILES DE LA INFANCIA

FOTO CLÍNICA




Imagen: Atlas EUNACOM 2026

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Manos edematosas y eritematosas

**DIAGNÓSTICO**

### Kawasaki: edema de manos

*Edema duro y eritema de palmas y plantas en la fase aguda.*

**CONDUCTA INICIAL**

Después aparece la descamación periungueal en dedo de guante.

2.01.1.058 Vasculitis: PSH, Kawasaki, otros

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Escarlatina: descamación también, sin edema indurado.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2017 · P128** «Un prescolar de 2 años, presenta un cuadro de fiebre alta, desde hace 5 días, asociado marcado decaimiento. Al examen físico presenta un exantema…» → **Enfermedad de Kawasaki**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 98** Tema 5.3

**Clase 5.3** en video

## 58 TEMA 5.3 · EXANTEMAS FEBRILES DE LA INFANCIA

FOTO CLÍNICA




Imagen: Fitzpatrick, Dermatology in General Medicine, p. 1639

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Púrpura palpable

**DIAGNÓSTICO**

### Púrpura de Schönlein-Henoch

*Púrpura palpable en extensores de las piernas y glúteos con plaquetas normales.*

**CONDUCTA INICIAL**

Vasculitis IgA: soporte; vigilar compromiso renal y abdominal.

2.01.1.058 **Vasculitis: PSH, Kawasaki, otros**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Púrpura meningocócica: febril, con shock.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 96** Tema 5.3

Clase 5.3 en video

## 59 TEMA 5.4 · VARICELA NO COMPLICADA VS COMPLICADA Y HERPES ZÓSTER

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual CTO Infecciosas 14.ª ed., p. 127

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Vesícula clara sobre base roja
2. Costras al lado de lesiones nuevas

**DIAGNÓSTICO**

### Varicela: polimorfismo regional

*Máculas, pápulas, vesículas y costras juntas en la misma zona («cielo estrellado»).*

**CONDUCTA INICIAL**

Adulto: aciclovir oral; contagiosa hasta que todas sean costras.

1.04.1.011 **Enfermedades eruptivas no complicadas (varicela, herpes zoster…)**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Viruela: lesiones en el mismo estadio.

PREGUNTA REAL **Julio 2013 · P118** «Hombre de 18 años, sin antecedentes, con cuadro de 3 días de compromiso del estado general, sensación febril, tos y coriza, que durante el último…» → **Aciclovir oral**

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 101** Tema 5.4

Clase 5.4 en video

## 60 TEMA 5.4 · VARICELA NO COMPLICADA VS COMPLICADA Y HERPES ZÓSTER

FOTO CLÍNICA




Imagen: Manual AMIR Infecciosas, p. 127

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Vesículas, pápulas y costras juntas

**DIAGNÓSTICO**

### Varicela: cielo estrellado en la espalda

*Lesiones en distintos estadios en la misma zona.*

**CONDUCTA INICIAL**

Contagiosa hasta que todas sean costras; aciclovir en adulto.

`1.04.1.011` **Enfermedades eruptivas no complicadas (varicela, herpes zoster...)**

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

**SE CONFUNDE CON...**

Viruela: lesiones en el mismo estadio.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 101** Tema 5.4

**Clase 5.4** en video

## 61 TEMA 5.4 · VARICELA NO COMPLICADA VS COMPLICADA Y HERPES ZÓSTER

IMAGEN RADIOLÓGICA

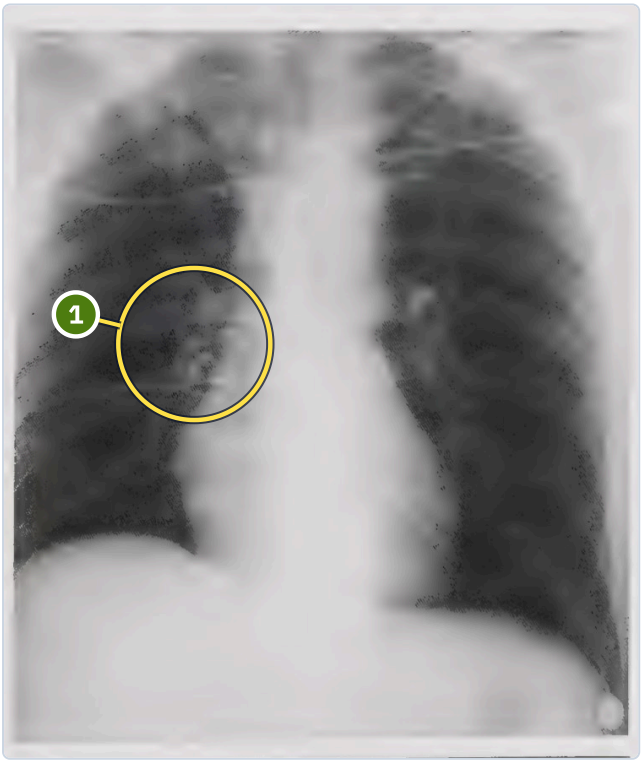



Imagen: Brant & Helms, Fundamentals of Diagnostic Radiology, p. 491

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Infiltrado nodular bilateral

**DIAGNÓSTICO**

### Neumonitis varicelosa

*Infiltrados nodulares difusos en ambos pulmones: la complicación más grave en adultos.*

**CONDUCTA INICIAL**

Aciclovir EV urgente.

`1.04.2.010` **Varicela complicada: neumonitis, cerebelitis, encefalitis**

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON...**

TBC miliar: micronódulos más finos y uniformes.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO INFECTOLOGÍA **p. 101** Tema 5.4

**Clase 5.4** en video

## 62 TEMA 5.5 · NEUTROPENIA FEBRIL POST-QUIMIOTERAPIA Y FIEBRE SIN FOCO

IMAGEN RADIOLÓGICA

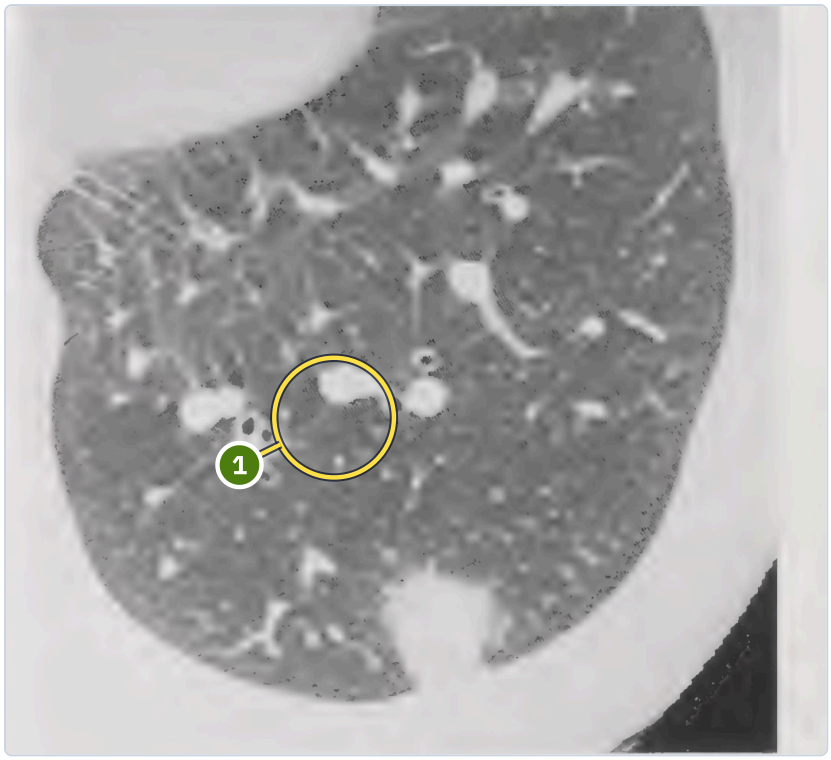



Imagen: Brant & Helms, Fundamentals of Diagnostic Radiology, p. 497

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Nódulo con halo

**DIAGNÓSTICO**

### Aspergilosis invasora: signo del halo

*Nódulo pulmonar rodeado de vidrio esmerilado en un neutropénico.*

**CONDUCTA INICIAL**

Fiebre persistente al 4.º-7.º día de neutropenia febril: TAC y voriconazol.

| | | |
|---|---|---|
| 1.04.1.019 | Micosis invasora (aspergillosis, candidiasis, mucormicosis) | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 1.04.1.020 | Neutropenia febril | Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Neumonía bacteriana: consolidación sin halo.

PREGUNTA REAL **Julio 2016 · P73** «Paciente con diagnóstico de una leucemia mieloide aguda, en su cuarto ciclo de quimioterapia, se encuentra hospitalizado por fiebre sin foco,…» → **Aspergilosis invasiva**

TOMO INFECTOLOGÍA p. 105 Tema 5.5

Clase 5.5 en video

## 63 TEMA 5.5 · NEUTROPENIA FEBRIL POST-QUIMIOTERAPIA Y FIEBRE SIN FOCO

FOTO CLÍNICA

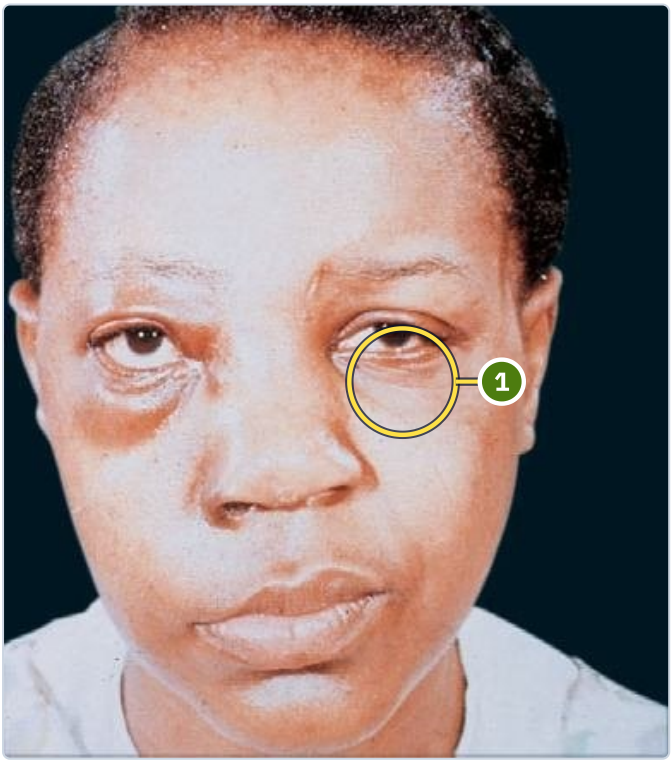



Imagen: Fitzpatrick, Dermatology in General Medicine, p. 1882

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Edema periorbitario y proptosis

**DIAGNÓSTICO**

### Mucormicosis rinocerebral

*Diabético descompensado con edema periorbitario, proptosis y escara negra.*

**CONDUCTA INICIAL**

Anfotericina B y desbridamiento quirúrgico urgente; corregir la cetoacidosis.

| | | |
|---|---|---|
| 1.04.1.019 | Micosis invasora (aspergillosis, candidiasis, mucormicosis) | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Celulitis orbitaria bacteriana: sin escara negra.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2018 · P124** «Un paciente de 41 años, diabético tipo 1, consulta por fiebre, asociado a rinorrea purulenta y enrojecimiento facial. Al examen físico, se…» → **Mucor**

TOMO INFECTOLOGÍA p. 105 Tema 5.5

Clase 5.5 en video

## 64 TEMA 5.6 · VIRUS RESPIRATORIOS

IMAGEN RADIOLÓGICA




Imagen: Nelson 22.ª ed., Fig. 311.4

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Asas intestinales de pared engrosada

**DIAGNÓSTICO**

### MIS-C: compromiso digestivo

*Asas con paredes engrosadas y ganglios mesentéricos 2-6 semanas tras COVID-19.*

**CONDUCTA INICIAL**

UCI pediátrica: inmunoglobulina y corticoides.

2.01.2.144 SARS Cov 2 COVID 19

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Apendicitis: el dolor y los vómitos pueden simularla.

**PREGUNTA REAL** **Agosto 2021 · P36** «Un adolescente de 14 años presenta un cuadro de fiebre de 39ºC, desde hace 3 días, asociado a malestar general, dolor abdominal, vómitos y…» → **Síndrome inflamatorio multisistémico**

TOMO INFECTOLOGÍA p. 109 Tema 5.6

Clase 5.6 en video

# Parecidas pero distintas

Las mismas fotos de las fichas, lado a lado y sin marcadores: primero intenta decir cuál es cuál.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

## Erisipela vs celulitis



VS



### A Erisipela

- Borde nítido y sobreelevado
- Dermis superficial: S. pyogenes

Ficha n.° 44 · p. 26

### B Celulitis

- Bordes difusos, sin relieve
- Subcutáneo: S. aureus y S. pyogenes

Ficha n.° 45 · p. 26

**LA DIFERENCIA** El borde te dice la profundidad, y la profundidad, el agente.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

## Herpes genital vs chancro



VS



### A Herpes genital

- Vesículas en racimo
- Erosiones dolorosas

Ficha n.° 26 · p. 16

### B Chancro sifilítico

- Úlcera única
- Indolora

Ficha n.° 21 · p. 14

**LA DIFERENCIA** El herpes es la úlcera genital más frecuente y la única que parte con vesículas.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

## Carbunco cutáneo vs loxoscelismo



VS



### A Carbunco cutáneo (pústula maligna)

- Escara negra con vesículas
- Indolora

Ficha n.º 40 · p. 24

### B Loxoscelismo cutáneo

- Placa livedoide con necrosis
- Muy dolorosa

Ficha n.º 42 · p. 25

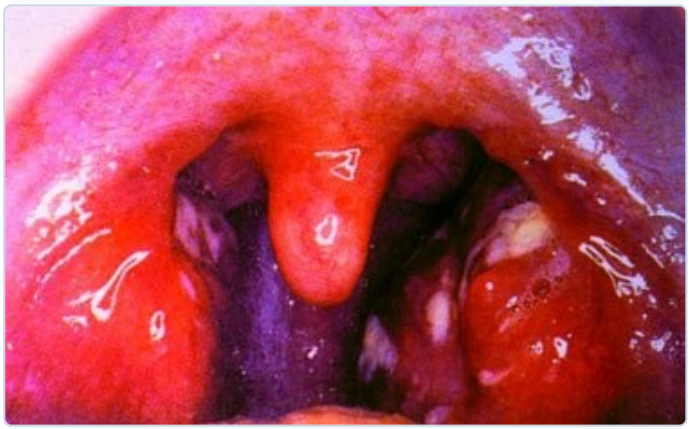
**LA DIFERENCIA** Escaras negras: la clave es el dolor.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

## Mononucleosis vs faringitis estreptocócica



VS



### A Amigdalitis del síndrome mononucleósico

- Exudado + adenopatías posteriores
- Esplenomegalia, linfocitos atípicos

Ficha n.º 49 · p. 28

### B Faringoamigdalitis estreptocócica

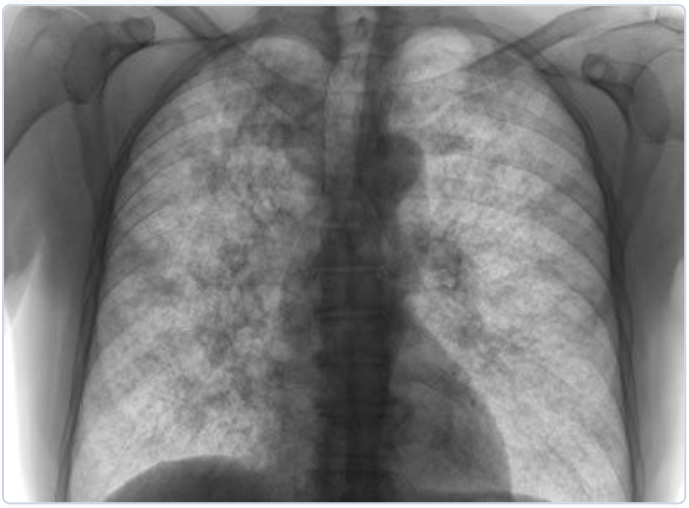
- Exudado pultáceo
- Fiebre sin esplenomegalia

Ficha n.º 50 · p. 29

**LA DIFERENCIA** Mirando la garganta no las separas: amoxicilina en la mononucleosis da exantema.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

## TBC miliar vs neumonitis varicelosa



VS



### A Tuberculosis miliar

- Micronódulos finos uniformes
- Siembra hematógena

Ficha n.º 17 · p. 12

### B Neumonitis varicelosa

- Infiltrado nodular difuso
- Adulto con varicela

Ficha n.º 61 · p. 34

**LA DIFERENCIA** El contexto clínico manda: exantema vesicular reciente o bacilo en el cultivo.

# Signos con nombre propio

Lo que el examen nombra con un epónimo o una imagen: qué es, en qué enfermedad aparece y dónde está en el tomo.



## SIGNO DE KERNIG

Con la cadera flectada, la extensión de la rodilla duele y ofrece resistencia.
**Se ve en:** Meningitis.

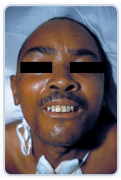
Tomo p. **10** · Atlas: ficha n.° 02, p. **4**

*sin foto en el atlas*

## SIGNO DE BRUDZINSKI

Al flectar el cuello se flectan las caderas y rodillas.
**Se ve en:** Meningitis.

Tomo p. **11**



## RISA SARDÓNICA

Mueca fija por espasmo de los músculos faciales.
**Se ve en:** Tétanos.

Tomo p. **28** · Atlas: ficha n.° 10, p. **8**



## OPISTÓTONOS

Arco dorsal rígido por contracción de los extensores.
**Se ve en:** Tétanos.

Tomo p. **28** · Atlas: ficha n.° 11, p. **9**



## SIGNO DE ROMAÑA

Edema bipalpebral unilateral indoloro con adenopatía preauricular.
**Se ve en:** Chagas agudo.

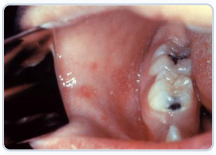
Tomo p. **66** · Atlas: ficha n.° 30, p. **18**



## SIGNO DEL CAMALOTE

Membrana germinativa desprendida flotando dentro del quiste.
**Se ve en:** Hidatidosis.

Tomo p. **75** · Atlas: ficha n.° 36, p. **22**



## MANCHAS DE KOPLIK

Pápulas blanquecinas en la mucosa yugal frente al segundo molar.
**Se ve en:** Sarampión.

Tomo p. **97** · Atlas: ficha n.° 52, p. **30**

*sin foto en el atlas*

## LÍNEAS DE PASTIA

Petequias lineales en los pliegues antecubitales e inguinales.
**Se ve en:** Escarlatina.

Tomo p. **98**

*sin foto en el atlas*

## FACIES DE FILATOV

Mejillas rojas con palidez peribucal.
**Se ve en:** Escarlatina.

Tomo p. **98**

*sin foto en el atlas*

## SIGNO DE LA BOFETADA

Eritema intenso de ambas mejillas.
**Se ve en:** Eritema infeccioso (parvovirus B19).

Tomo p. **98**

# Signos con nombre propio · continuación

*sin foto en el atlas*

## SIGNO DE HUTCHINSON (ZÓSTER)

Vesícula en la punta de la nariz (rama nasociliar de V1).
**Se ve en:** Zóster oftálmico con riesgo de queratitis.

Tomo p. 102

*sin foto en el atlas*

## SIGNO DE FAGET

Fiebre alta con bradicardia relativa (disociación esfigmotérmica).
**Se ve en:** Fiebre tifoidea.

Tomo p. 78



## CIELO ESTRELLADO

Lesiones en distintos estadios en la misma zona.
**Se ve en:** Varicela.

Tomo p. 101 · Atlas: ficha n.° 59, p. 33

*sin foto en el atlas*

## SIGNO DEL HALO

Nódulo pulmonar rodeado de vidrio esmerilado en la TAC.
**Se ve en:** Aspergilosis invasora.

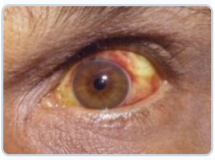
Tomo p. 105



## TRÍADA DE HUTCHINSON

Dientes de Hutchinson, queratitis intersticial y sordera.
**Se ve en:** Sífilis congénita tardía.

Tomo p. 50 · Atlas: ficha n.° 24, p. 15



## SÍNDROME DE WEIL

Ictericia, falla renal y hemorragia pulmonar.
**Se ve en:** Leptospirosis grave.

Tomo p. 78 · Atlas: ficha n.° 38, p. 23

*sin foto en el atlas*

## SÍNDROME DE RAMSAY-HUNT

Parálisis facial periférica con vesículas en el conducto auditivo o la concha.
**Se ve en:** Zóster del ganglio geniculado.

Tomo p. 102

# Índice por tipo de imagen

| 41 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| FOTO CLÍNICA | HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA | IMAGEN RADIOLÓGICA | OTRA (AGENTE O VECTOR) | TRAZADO (ECG / REGISTRO) | ECOGRAFÍA |


## Foto clínica · 41

01 Rigidez de nuca (1.2) ..... 4
02 Signo de Kernig (1.2) ..... 4
03 Púrpura meningocócica (1.2) ..... 5
07 Gangrena de Fournier (1.4) ..... 7
08 Fascitis necrotizante tras el desbridamiento (1.4) ..... 7
09 Angina de Ludwig (1.4) ..... 8
10 Tétanos: risa sardónica y trismus (2.2) ..... 8
11 Tétanos: opistótonos (2.2) ..... 9
12 Cólera: heces en agua de arroz (2.4) ..... 9
13 Botulismo del lactante (2.4) ..... 10
15 Sarcoma de Kaposi (3.2) ..... 11
19 Escrófula (adenitis tuberculosa) (3.3) ..... 13
21 Chancro sifilítico (3.4) ..... 14
22 Sífilis secundaria palmar (3.4) ..... 14
23 Condilomas planos (3.4) ..... 15
24 Dientes de Hutchinson (3.4) ..... 15
25 Uretritis gonocócica (3.5) ..... 16
26 Herpes genital (3.5) ..... 16
30 Signo de Romaña (4.2) ..... 18
32 Exantema del dengue (4.3) ..... 20
38 Leptospirosis: sufusión conjuntival (4.5) ..... 23
39 Fiebre tifoidea: roséola tífica (4.5) ..... 23
40 Carbunco cutáneo (pústula maligna) (4.6) ..... 24
42 Loxoscelismo cutáneo (4.6) ..... 25
43 Ectima gangrenoso (Pseudomonas) (4.6) ..... 25
44 Erisipela (5.1) ..... 26
45 Celulitis (5.1) ..... 26
46 Foliculitis (5.1) ..... 27
47 Ántrax estafilocócico (5.1) ..... 27
49 Amigdalitis del síndrome mononucleósico (5.2) ..... 28
50 Faringoamigdalitis estreptocócica (5.2) ..... 29
52 Manchas de Koplik (5.3) ..... 30
53 Exantema del sarampión (5.3) ..... 30
54 Exantema de la rubéola (5.3) ..... 31
55 Kawasaki: labios fisurados y lengua en frambuesa (5.3) ..... 31
56 Kawasaki: conjuntivitis bulbar sin pus (5.3) ..... 32
57 Kawasaki: edema de manos (5.3) ..... 32
58 Púrpura de Schönlein-Henoch (5.3) ..... 33
59 Varicela: polimorfismo regional (5.4) ..... 33
60 Varicela: cielo estrellado en la espalda (5.4) ..... 34
63 Mucormicosis rinocerebral (5.5) ..... 35

## Histología / citología · 5

04 Gram del LCR (1.2) ..... 5
20 Baciloscopía: tinción de Ziehl-Neelsen (3.3) ..... 13
33 Malaria: trofozoítos en anillo (4.3) ..... 20
34 Gametocitos en banana (P. falciparum) (4.3) ..... 21
48 Linfocitos atípicos (de Downey) (5.2) ..... 28

## Imagen radiológica · 14

05 Encefalitis herpética en RM (1.3) ..... 6
06 Abscesos cerebrales en anillo (1.3) ..... 6
14 Neumonía por Pneumocystis jirovecii (3.2) ..... 10
16 Toxoplasmosis cerebral (3.2) ..... 11
17 Tuberculosis miliar (3.3) ..... 12
18 Pleuritis tuberculosa: derrame unilateral (3.3) ..... 12
27 Hantavirus: edema intersticial inicial (4.1) ..... 17
28 Hantavirus: edema pulmonar extenso (4.1) ..... 17
36 Quiste hidatídico: signo del camalote (4.4) ..... 22
37 Quiste hidatídico pulmonar (4.4) ..... 22
41 Carbunco inhalatorio: mediastino ensanchado (4.6) ..... 24
61 Neumonitis varicelosa (5.4) ..... 34
62 Aspergilosis invasora: signo del halo (5.5) ..... 35
64 MIS-C: compromiso digestivo (5.6) ..... 36

## Otra (agente o vector) · 1

29 Vinchuca (Triatoma infestans) (4.2) ..... 18

## Trazado (ECG / registro) · 1

31 Cardiopatía chagásica: BCRD + HBAI (4.2) ..... 19

## Ecografía · 2

35 Quiste hidatídico hepático: vesículas hijas (4.4) ..... 21
51 CMV congénito: calcificaciones periventriculares (5.2) ..... 29

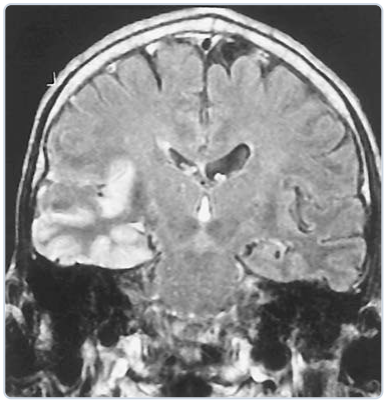
# Autoevaluación

32 fotos de las fichas, sin marcadores ni rótulos. Escribe el diagnóstico y el hallazgo que lo confirma; las soluciones están al final.

**1** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**2** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



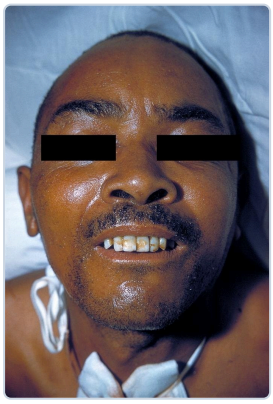
**3** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**4** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**5** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



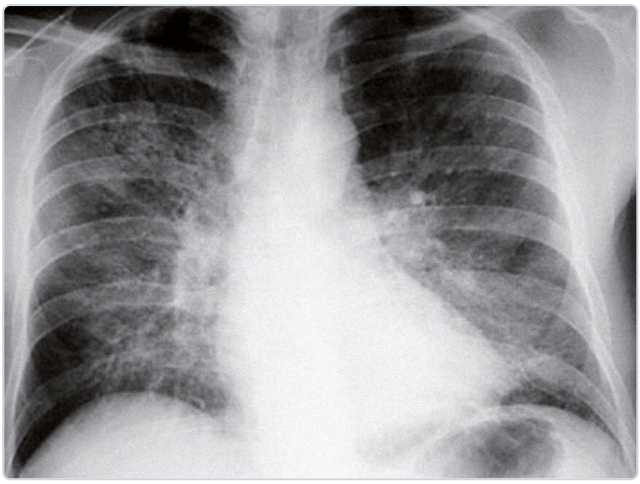
**6** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**7** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



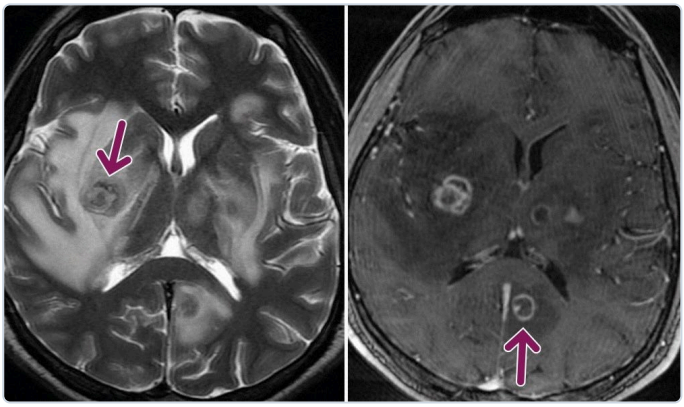
**8** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



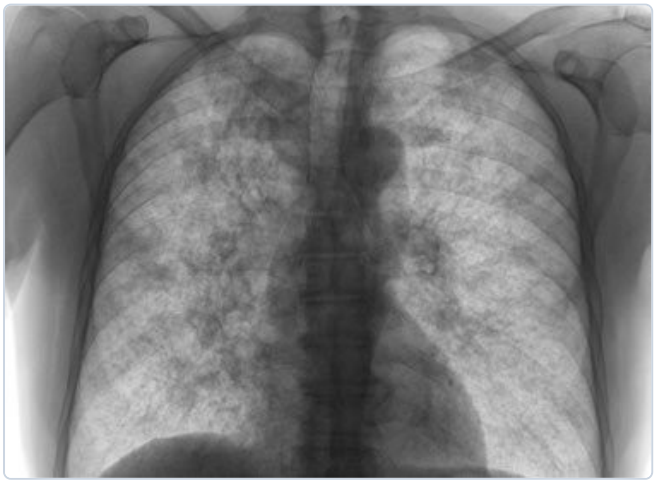
**9** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**10** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**11** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**12** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**13** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**14** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



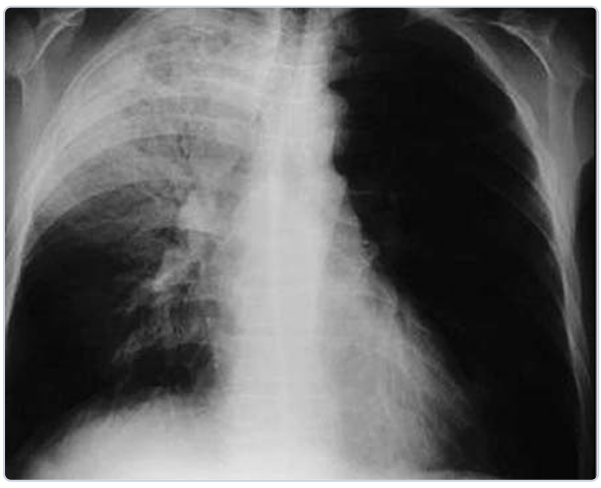
**15** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**16** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**17** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



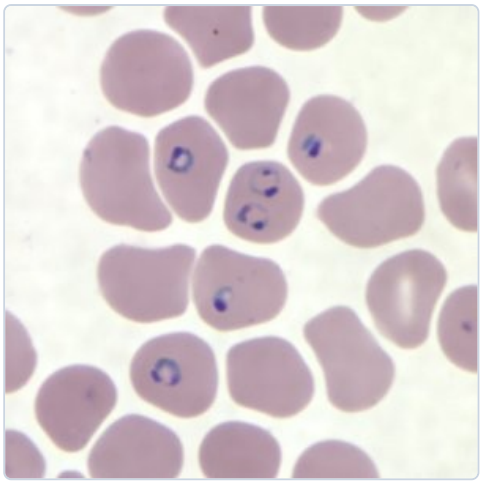
**18** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**19** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



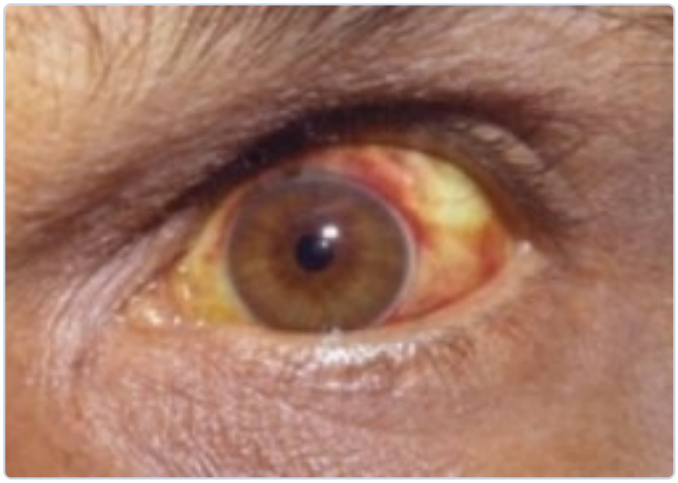
**20** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**21** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**22** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**23** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**24** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



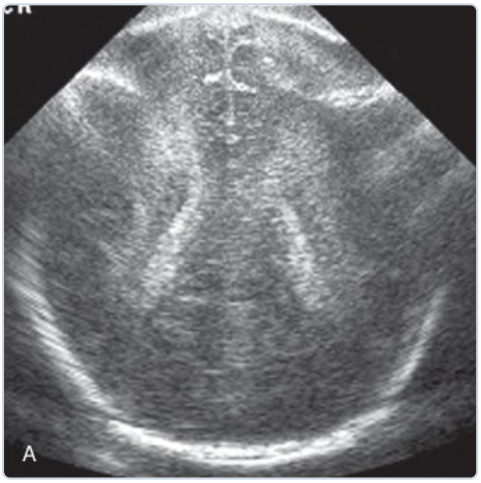
**25** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



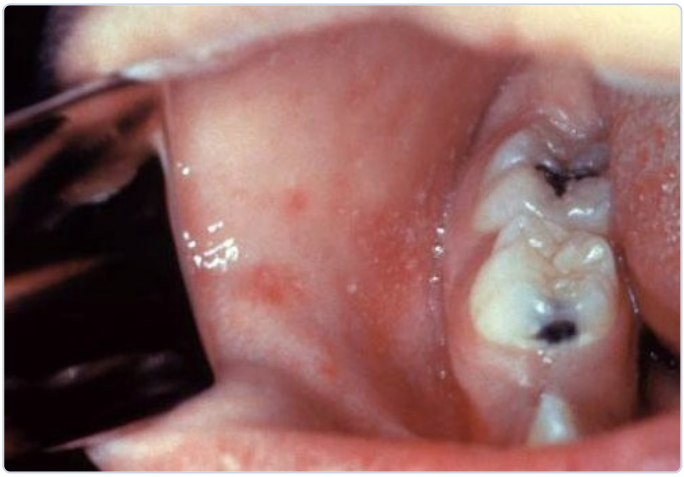
**26** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**27** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?




**28** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**29** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**30** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**31** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**32** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



# Soluciones de la autoevaluación

| N.º | DIAGNÓSTICO | LO QUE LO CONFIRMA | FICHA |
|---|---|---|---|
| 1 | **Púrpura meningocócica** | Púrpura extensa que no blanquea | 03 · p. 5 |
| 2 | **Encefalitis herpética en RM** | Lóbulo temporal hiperintenso | 05 · p. 6 |
| 3 | **Gangrena de Fournier** | Piel violácea y necrótica en el periné | 07 · p. 7 |
| 4 | **Angina de Ludwig** | Aumento de volumen bajo la mandíbula | 09 · p. 8 |
| 5 | **Tétanos: risa sardónica y trismus** | Mueca fija de la boca | 10 · p. 8 |
| 6 | **Cólera: heces en agua de arroz** | Heces líquidas con grumos blancos | 12 · p. 9 |
| 7 | **Botulismo del lactante** | Cara inexpresiva, hipotonía | 13 · p. 10 |
| 8 | **Neumonía por Pneumocystis jirovecii** | Infiltrado intersticial bilateral | 14 · p. 10 |
| 9 | **Sarcoma de Kaposi** | Placas violáceas en la pierna | 15 · p. 11 |
| 10 | **Toxoplasmosis cerebral** | Lesión en los ganglios basales (flecha) | 16 · p. 11 |
| 11 | **Tuberculosis miliar** | Micronódulos difusos en ambos pulmones | 17 · p. 12 |
| 12 | **Chancro sifilítico** | Úlcera de fondo limpio | 21 · p. 14 |
| 13 | **Sífilis secundaria palmar** | Máculas y pápulas en la palma | 22 · p. 14 |
| 14 | **Dientes de Hutchinson** | Incisivos con muesca en el borde | 24 · p. 15 |
| 15 | **Uretritis gonocócica** | Gota de pus en el meato | 25 · p. 16 |
| 16 | **Herpes genital** | Vesículas y erosiones agrupadas | 26 · p. 16 |
| 17 | **Hantavirus: edema pulmonar extenso** | Opacidad extensa bilateral | 28 · p. 17 |
| 18 | **Signo de Romaña** | Edema palpebral unilateral | 30 · p. 18 |
| 19 | **Exantema del dengue** | Islas de piel sana dentro del eritema | 32 · p. 20 |
| 20 | **Malaria: trofozoítos en anillo** | Trofozoíto en anillo intraeritrocitario | 33 · p. 20 |
| 21 | **Quiste hidatídico: signo del camalote** | Membranas desprendidas en el quiste (flecha) | 36 · p. 22 |
| 22 | **Leptospirosis: sufusión conjuntival** | Conjuntiva roja sin pus | 38 · p. 23 |
| 23 | **Carbunco cutáneo (pústula maligna)** | Escara negra central | 40 · p. 24 |
| 24 | **Erisipela** | Borde nítido y sobreelevado | 44 · p. 26 |
| 25 | **Celulitis** | Eritema difuso de la pierna | 45 · p. 26 |
| 26 | **Amigdalitis del síndrome mononucleósico** | Amígdalas hipertróficas con exudado | 49 · p. 28 |
| 27 | **CMV congénito: calcificaciones periventriculares** | Calcificaciones periventriculares | 51 · p. 29 |
| 28 | **Manchas de Koplik** | Puntos blancos sobre mucosa roja | 52 · p. 30 |
| 29 | **Exantema del sarampión** | Exantema maculopapular confluente | 53 · p. 30 |
| 30 | **Kawasaki: labios fisurados y lengua en frambuesa** | Labios rojos y fisurados | 55 · p. 31 |
| 31 | **Púrpura de Schönlein-Henoch** | Púrpura palpable | 58 · p. 33 |
| 32 | **Varicela: polimorfismo regional** | Vesícula clara sobre base roja | 59 · p. 33 |